



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**SK INDIKATOR MUTU DAN KAMUS INDIKATOR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR: 058.2/I-KEP/DIR/I/2025

TENTANG

INDIKATOR MUTU DAN KAMUS INDIKATOR RS PRIMA HUSADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi, nilai pelayanan kepada pasien;

b.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Malang

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu penetapan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada profil indikator mutu Rumah Sakit Prima Husada Malang;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;

5.

Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.14/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Malang;

6.

Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001.204/DPM/I-KEP/DIR/I/2024 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

INDIKATOR MUTU DAN KAMUS INDIKATOR RS PRIMA HUSADA MALANG
- Kesatu

:

Menetapkan profil indikator mutu RS Prima Husada Malang
- Kedua

:

Masa kerja tim ditetapkan sampai waktu yang ditentukan
- Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKITPRIMA HUSADA
NOMOR 058.2/I-KEP/DIR/I/2025
TENTANG PROFIL INDIKATOR MUTU
DAN KAMUS INDIKATOR MUTU
RS PRIMA HUSADA MALANG

Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND
INDIKATOR MUTU NASIONAL		
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%

Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No	JUDUL INDIKATOR	STAN
1	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%
2	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%
3	Kejadian Ketidaktepatan waktu pelaporan hasil kritis gula darah (Lab)	0
4	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0

5	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai (Farmasi)	100%
6	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%
7	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%
8	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%
10	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%

Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand
1	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%
2	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%

Tujuan Strategis

No	Judul	Standart
1	Kepuasan Pasien	85%

Perbaikan Sistem

No	Judul	Standart
1	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%

Indikator Mutu Unit

1. Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%
7.	Kepuasan pasien	85%
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%
10.	Kejadian Ketidaktepatan waktu pelaporan hasil kritis gula darah (Lab)	100%
11.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%
12.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
13.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%

14.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%
15.	Angka kepatuhan teiage untuk penyakit menular di IGD	100%
16.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%
19.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%
20.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0
21.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%
23.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%
24.	Kegiatan merujuk pasien	0

2. Rawat Inap

NO	JUDUL	STAND
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%
9.	Kepuasan pasien	85%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%

18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%
24.	Kejadian merujuk pasien	0
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%

3. ICU

NO	JUDUL	STAND
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%
8.	Kepuasan pasien	85%
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%
15.	Angka efektivitas discharge planning	100%
16.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	
17.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%
20.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%

21.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%
22.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%
23.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%
24.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%
25.	Kejadian merujuk pasien	0
26.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%

4. HCU

NO	JUDUL	STAND
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%
8.	Kepuasan pasien	85%
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%
15.	Angka efektivitas discharge planning	100%
16.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	
17.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%
20.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%
21.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%
22.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%
23.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%

24.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%
25.	Kejadian merujuk pasien	0
26.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%

5. IRJA

NO	JUDUL	STAND
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%
7.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%
8.	Kepuasan pasien	85%
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
10.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%
11.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%
12.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%
13.	Kejadian merujuk pasien	0
14.	Angka kelengkapan inform concent	100%
15.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%
16.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%

6. Maternitas

No	Judul	Standart
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%
4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%
8.	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%
10.	Kejadian perdarahan post partum	0
11.	Kejadian partus macet	0

12.	Kejadian eklamsi	0
13.	Kejadian pre eklamsi	0
14.	Kejadian infeksi nifas	0
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%
22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%
27.	Angka efektivitas discharge planning	100%
28.	Angka Kelengkapan Follow up Discharge Planing	100%
30.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%
31.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
32.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%
33.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%
34.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0
35.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%

7. NICU

NO	JUDUL	STAND
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%

8.	Kepuasan Pasien	85%
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (neonatus)	100%
26.	Kejadian Merujuk Pasien	0

8. PICU

NO	JUDUL	STAND
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%
8.	Kepuasan Pasien	85%
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%

12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%
25.	Kejadian Merujuk Pasien	0

8. IKO

No	Judul	Standart
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%
4.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0
9.	Kelengkapan Pelayanan Anastesi sesuai prosedur	
10.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0
11.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0
12.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0
13.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0
14.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0
15.	Kelengkapan Daftar Tilik Pasien Operasi	100%
16.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0

17.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0
18.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0
19.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%
21.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%
22.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%
23.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%
24.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%
25.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%
26.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%
27.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%
28.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%
29.	Angka efektivitas discharge planning	100%
30.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%
31.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%

9. Laboratorium

No	Judul	Stand
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%
5.	Survilen harian hemofiglen	100%
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%
12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	

10. Radiologi

No	Judul	Standart
1.	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi (mutu prioritas unit)	0%
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
3.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis Radiologi kurang dari 30 menit	0%

4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

11. Gizi

No	Judul	Stand
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dan lanjut)	100%
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

12. Instalasi Farmasi

No	Judul	Stand
1.	Angka ketersediaan obat-obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0
15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%
16.	Kepatuhan penyimpanan obat-obatan emergency disimpan secara seragam	100%
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	0
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu diwaspadai	100%

20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single use dan multi dose vial	100%
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%

13. Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand
1.	Kekosongan Stok Sediaan Farmasi (mutu prioritas unit)	0
2.	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan OBAT	100%

14. PPI

No.	Judul	Standart
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %
6.	Decubitus	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0

15. PIPP

No	Judul	Standart
1.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%

2.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%
3.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%
4.	Angka Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%
5.	Kepuasan Pasien	76,61%
6.	Kepatuhan petugas dalam mengumpulkan kuesioner complain dan kepuasan pelanggan	100%
7.	Kepuasan pasien BPJS	100%
8.	Angka kelengkapan dokumentasi tindak lanjut manajemen komplain	100%

16. SDM

No	Judul	Standart
1.	Angka keterlambatan kehadiran staf (mutu prioritas unit)	0%
2.	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0
3.	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%

17. Rekam Medis

No	Judul	Standart
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%

18. K3RS

No	Judul	Standart
1.	Kejadian kebakaran di ruangan (mutu prioritas)	0
2.	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan hydran setiap 6 bulan	100%
3.	Kejadian tenaga kesehatan sakit akibat kerja	0
4.	Kepatuhan pelaksanaan MCU tenaga kesehatan diarea risiko tinggi	100%

19. Asuransi Center

No	Judul	Standart
----	-------	----------

1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim (mutu prioritas unit)	0
2.	Angka pending klaim BPJS	0%
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%
5.	Keterlambatan pengumpulan DRM pasien rawat inap lebih dari 24 JAM	0%

20. IPSRS

No	Judul	Standart
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim (mutu prioritas unit)	0
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (sarana prasarana dan fasilitas)	0%

21. UMUM

No	Judul	Stand
1.	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit (mutu prioritas unit)	0
2.	Keterlambatan barang datang di Gudang	0

22. Cleaning Service

No	Judul	Standart
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit (mutu prioritas unit)	0%
2.	Kejadian Komplain Kebersihan Kamar Mandi	0
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

23. KESEKRETARIATAN

No	Judul	Standart
1.	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya (mutu prioritas unit)	0%
2.	Angka ketidaklengkapan pengumpulan notulen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%
3.	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%

24. Laundry

No	Judul	Standart
1.	Kejadian ditemukan benda asing (mutu prioritas unit)	0
2.	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%
3.	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0
4.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
5.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

25. CSSD

No	Judul	Standart
1.	Kejadian instrument kurang (mutu prioritas unit)	0

2.	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

26. Humas dan Pemasaran

No	Judul	Standart
1.	Angka kunjungan pasien baru IGD rawat inap 30 perhari (mutu prioritas unit)	100%
2.	Angka kunjungan pasien rencana operasi	100%
3.	Angka kunjungan rawat jalan >400 pasien perhari	100%
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%

27. IT

No	Judul	Standart
1	Resptime penanganan kejadian downtime tidak terencana (mutu prioritas unit)	0
2	Resptime penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%
3	Resptime untuk penanganan computer < 15 menit	100%

29. Kamar Jenazah

No	Judul	Standart
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) (mutu prioritas unit)	≤ 2 Jam
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%
3.	Kepatuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%

30. PKRS

No	Judul	Standart
1.	Kepatuhan pelaksanaan edukasi sesuai jadwal	100%

31. Driver

No	Judul	Standart
1	Resptime panggilan driver < 10 menit on call (mutu prioritas unit)	100%
2	Resptime panggilan driver < 30 menit on call	100%
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%
5	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%

32. Security

No	Judul	Standart
1.	Kejadian ditemukannya merokok, puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0
2.	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0
3.	Kejadian potensial barang hilang	0
4.	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0

KAMUS INDIKATOR RS PRIMA HUSADA
KAMUS INDIKATOR MUTU NASIONAL

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19). 4. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai dengan ketentuan WHO.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60-80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan. 4. Lima indikasi (<i>five moment</i>) kebersihan tangan terdiri dari: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh : pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain-lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, <i>feces</i>, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD.

	e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan. 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥ 85%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan . Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kepatuhan Kebersihan Tangan
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien. 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19). 4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD). 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan penggunalayanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, <i>droplet</i> dan <i>airborne</i>). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi. 4. Petugas adalah seluruh tenaga yang terindikasi menggunakan APD, contoh dokter, dokter gigi, bidan, perawat, petugas laboratorium. 5. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 6. Periode observasi adalah waktu yang ditentukan sebagai periode yang ditetapkan dalam proses observasi penilaian kepatuhan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi

Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi $\frac{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel ☐ √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Keselamatan Pasien. 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit.

	3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) danatau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakanintervensi pasien seperti : a. Pemberian pengobatan : pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah danproduk darah, radioterapi, dan nutrisi. b. Prosedur tindakan : tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. c. Prosedur diagnostik : pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. d. Kondisi tertentu : pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi,pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanankesehatan. Kriteria Eksklusi:Tidak ada
Formula	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi $\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

4. Waktu Tanggap Operasi Sesarea Emergensi

Judul Indikator	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi
Dasar Pemikiran	6. Undang Undang tentang Rumah Sakit 7. Berdasarkan SUPAS tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2015 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, ini masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Kejadian kematian ibu ini terbanyak ditemukan di rumah sakit sebesar 78%. Tingginya Angka Kematian Ibu ini mengindikasikan masih perlunya dilakukan peningkatan tata kelola dan peningkatan mutu pelayanan <i>antenatal care</i> dan persalinan. Untuk itu diperlukan indikator untuk memantau kecepatan proses pelayanan operasi seksio sesarea.
Dimensi Mutu	Tepat Waktu, Efektif, Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya pelayanan kegawatdaruratan operasi seksio sesarea yang cepat dan tepat sehingga mampu mengoptimalkan upaya menyelamatkan Ibu dan Bayi
Definisi Operasional	1. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan tindakan seksio sesarea emergensi sejak diputuskan operasi sampai dimulainya insisi operasi di kamar operasi yaitu ≤ 30 menit. 2. Seksio sesarea emergensi adalah tindakan seksio sesarea yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan/atau bayi dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. 3. Seksio sesarea emergensi kategori I adalah tindakan seksio sesarea pada keadaan di mana terdapat ancaman langsung bagi kelangsungan hidup ibu atau janin. 4. Pengukuran indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi dilakukan oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan seksio sesaria.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I (satu) yang mendapatkan tindakan seksio sesarea emergensi ≤ 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I
Target Pencapaian	$\geq 80\%$
Kriteria	Kriteria Inklusi: Seksio sesarea emergensi kategori I Misalnya : <i>fetal distress</i> menetap, prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung, gagal vakum/forsep, <i>ruptur uteri imminent</i> , <i>ruptur uteri</i> , perdarahan <i>ante partum</i> dengan perdarahan aktif, Persalinan pada Bekas Seksio Sesarea (PBS) Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I yang mendapatkan tindakan seksio

	sesarea ≤ 30 menit x100% Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari rekam medik, laporan operasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Waktu Tanggap Seksio Sesarea Emergensi
Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Sampel	Total sampel
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

Judul Indikator	Waktu Tunggu Rawat Jalan
Dasar Pemikiran	1. Undang-Undang tentang Rumah Sakit. 2. Rumah sakit harus menjamin ketepatan pelayanan kesehatan termasuk di unit rawat jalan. Walaupun tidak dalam kondisi gawat maupun darurat namun tetap harus dilayani dalam waktu yang ditetapkan. Halini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pasien akan rencana diagnosis dan pengobatan. Waktu tunggu yang lama dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien dan keterlambatan diagnosis maupun pengobatan pasien.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien, tepat waktu
Tujuan	Tergambarnya waktu pasien menunggu di pelayanan sebagai dasar untuk perbaikan proses pelayanan di unit rawat jalan agar lebih tepat waktu dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Waktu tunggu rawat jalan adalah waktu yang dibutuhkan mulai saat pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan dokter/dokter spesialis. 2. Kontak dengan petugas pendaftaran adalah proses saat petugas pendaftaran menanyakan dan mencatat/menginput data sebagai pasien atau pada saat pasien melakukan konfirmasi kehadiran untuk pendaftaran <i>online</i>. a. pasien datang langsung, maka dihitung sejak pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis. b. pasien mendaftar <i>online</i>, maka dihitung sejak pasien melakukan konfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran sesuai jam pelayanan pada pendaftaran <i>online</i> sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis.

	c. Pasien anjungan mandiri, maka dihitung sejak buktipendaftaran tercetak pada anjungan mandiri sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria	Kriteria inklusi : Pasien yang berobat di rawat jalan Kriteria eksklusi: Pasien <i>medical check up</i>, pasien poli gigi Pasien yang mendaftar <i>online</i> atau anjungan mandiri datang lebih dari 60 menit dari waktu yang sudah ditentukan Pasien yang ada tindakan pasien sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu} \leq 60 \text{ menit}}{\text{Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sumber data sekunder antara lain dari: 1. Catatan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 2. Rekam Medik Pasien Rawat Jalan 3. Formulir Waktu Tunggu Rawat Jalan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Waktu Tunggu Rawat jalan
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling/Stratified Random sampling</i> (berdasar poliklinik rawat jalan)
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel ☐ √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan

6. Penundaan Operasi Elektif

Judul Indikator	Penundaan Operasi Elektif
Dasar Pemikiran	3. Undang-Undang tentang Rumah Sakit 4. Rumah sakit harus menjamin ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan termasuk tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan

	hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi.
Dimensi Mutu	Tepat waktu, efisiensi, berorientasi pada pasien
Tujuan	Tergambarnya ketepatan pelayanan bedah dan penjadwalan operasi.
Definisi Operasional	1. Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda lebih dari 1 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien operasi elektif
Target Pencapaian	≤ 5%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Pasien operasi elektif Kriteria Eksklusi: Penundaan operasi atas indikasi medis
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda lebih dari 1 jam}}{\text{Jumlah pasien operasi elektif}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari catatan pasien yang dijadwalkan operasi dan data pelaksanaan operasi.
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Penundaan Operasi Elektif
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel ☐ √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah/Bedah Sentral

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar Pemikiran	1. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang tentang pelayanan publik

	3. Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumahsakit.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien
Tujuan	a. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. b. Waktu yang ditetapkan untuk <i>visite</i> adalah pukul 06.00 - 14.00.
Definisi Operasional	Waktu <i>visite</i> dokter adalah waktu kunjungan dokter untuk melihat perkembangan pasien yang menjadi tanggungjawabnya.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di- <i>visite</i> dokter pada pukul 06.00 - 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria	Kriteria Inklusi: • <i>Visite</i> dokter pada pasien rawat inap Kriteria Eksklusi: • Pasien yang baru masuk rawat inap hari itu • Pasien konsul
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang di-visitedokter pada pukul 06.00-14.00}}{\text{Jumlah pasien yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder berupa laporan <i>visite</i> rawat inap dalamrekam medik
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kepatuhan Waktu <i>Visite</i> Dokter
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Stratified Random Sampling</i> (berdasarkan unit pelayanan)
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat inap

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Judul Indikator	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
Dasar Pemikiran	b. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien. c. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil laboratorium kritis sangat penting dalam kelanjutan tata laksana pasien. Hasil kritis menunjukkan kondisi pasien yang membutuhkan keputusan klinis yang segera untuk upaya pertolongan pasien dan mencegah komplikasi akibat keterlambatan.
Dimensi Mutu	Tepat waktu, keselamatan
Tujuan	1. Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium. 2. Tergambarnya sistem yang menunjukkan bagaimana nilai kritis dilaporkan dan didokumentasikan untuk menurunkan risiko keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Hasil kritis adalah hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis sesuai kebijakan rumah sakit dan memerlukan penatalaksanaan segera. 2. Waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu yang dibutuhkan sejak hasil pemeriksaan keluar dan telah dibaca oleh dokter/analisis yang diberi kewenangan hingga dilaporkan hasilnya kepada dokter yang meminta pemeriksaan. 3. Standar waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu pelaporan ≤ 30 menit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah hasil kritis laboratorium yang dilaporkan ≤ 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah hasil kritis laboratorium yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua hasil pemeriksaan laboratorium yang memenuhi kategori hasil kritis. Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	$\frac{\text{jumlah hasil kritis laboratorium yang dilaporkan} \leq 30 \text{ menit}}{100\% \text{ jumlah hasil kritis laboratorium yang diobservasi}} \times$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari: Catatan Data Laporan Hasil Tes Kritis Laboratorium
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling / Systematic Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan

□

□

Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

• Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Dasar Pemikiran	a. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional. b. Kepatuhan terhadap formularium dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan obat-obatan. c. Formularium rumah sakit disusun berdasarkan masukan-masukan pemberi layanan, dan pemilihannya berdasarkan kepada mutu obat, rasio risiko dan manfaat, berbasis bukti, efektivitas dan efisiensi. Pengadaan obat-obatan di rumah sakit mengacu pada formularium rumah sakit.
Dimensi Mutu	Efisien dan efektif
Tujuan	Terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium nasional.
Definisi Operasional	1. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. 2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional adalah peresepan obat (R/ : <i>recipe</i> dalam lembar resep) oleh DPJP kepada pasien sesuai daftar obat di Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah R/ <i>recipe</i> dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional
Denominator (penyebut)	Jumlah R/ <i>recipe</i> dalam lembar resep yang diobservasi
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Resep yang dilayani di RS Kriteria Eksklusi : 1. Obat yang diresepkan di luar FORNAS tetapi dibutuhkan pasien dan telah mendapatkan persetujuan komite medik dan direktur. 2. Bila dalam resep terdapat
Formula	$\frac{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional}}{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Lembar resep di Instalasi Farmasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling/ Systematic random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel ✓ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi

- Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
Dasar Pemikiran	a.Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran b.Permenkes tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Untuk menjamin kepatuhan dokter atau dokter gigi di rumah sakit terhadap standar pelayanan maka perlu dilakukan monitor kepatuhan penggunaan <i>clinical pathway</i>. c. Kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> yang telah ditetapkan. d.Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah : a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan e.Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	Efektif, integrasi
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit.

Definisi Operasional	1. <i>Clinical Pathway</i> adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 2. Kepatuhan terhadap <i>clinical pathway</i> adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan <i>clinical pathway</i> yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan <i>clinical pathway</i>
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada <i>clinical pathway</i> yang diobservasi
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur Kriteria Eksklusi : 1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan } \textit{clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada } \textit{clinical pathway} \text{ yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari rekam medis pasien
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kepatuhan <i>Clinical Pathway</i>
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Stratified Random Sampling</i> (berdasarkan masing-masing <i>Clinical Pathway</i>)
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Bidang Pelayanan Medik, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan lain

- Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Dasar Pemikiran	Permenkes tentang Keselamatan Pasien
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	2. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. <i>Assesment</i> awal risiko jatuh b. <i>Assesment</i> ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 3. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh Kriteria Eksklusi : Pasien yang tidak dapat dilakukan asesmen ulang maupun edukasi seperti pasien meninggal, pasien gangguan jiwa yang sudah melewati fase akut, dan pasien menolak intervensi
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{100\% \times \text{Jumlah pasien yang berisiko tinggi Jatuh yang diobservasi}}$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Stratified Random Sampling</i> (berdasarkan Unit Pelayanan)
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan Komite Keselamatan pasien

- Kecepatan Tanggap Komplain

Judul Indikator	Kecepatan Tanggap Komplain
-----------------	----------------------------

Dasar Pemikiran	4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 bahwa setiap pasien mempunyai mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 5. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Apabila selama perawatan pasien merasa bahwa rumah sakit belum menunaikan kewajiban tersebut maka pasien memiliki hak untuk mengajukankomplain. 6. Untuk itu rumah sakit perlu memiliki unit yang merespon dan menindaklanjuti keluhan tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan agar keluhan pasien dapat segera teratasi.
Dimensi Mutu	Berorientasi pada Pasien
Tujuan	Tergambarnya kecepatan rumah sakit dalam merespon keluhan pasien agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk sebagai bentuk pemenuhan hak pasien.
Definisi Operasional	1. Kecepatan waktu tanggap komplain adalah rentang waktu Rumah sakit dalam menanggapi keluhan tertulis, lisan atau melalui media massa melalui tahapan identifikasi, penetapan <i>grading</i> risiko, analisis hingga tindak lanjutnya. 2. <i>Grading</i> risiko dan standar waktu tanggap komplain: <i>Grading</i> Merah (ekstrim) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam sejak keluhan disampaikan oleh pasien/ keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/ kelangsungan organisasi, potensi kerugian material, dan lain-lain. <i>Grading</i> Kuning (tinggi) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien/ keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian immaterial, dan lain-lain. <i>Grading</i> Hijau (rendah) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien/ keluarga/pengunjung. Kriteria: tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah komplain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan <i>grading</i>
Denominator (penyebut)	Jumlah komplain yang disurvei
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua komplain (lisan, tertulis, dan media massa)

	Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah komplain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai waktu yang ditetapkan sesuai dengan } grading}{100\%} \times \text{Jumlah komplain yang disurvei}$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari catatan Komplain
Instrumen Pengumpulan Data	1. Formulir Komplain 2. Laporan Tindak Lanjut Komplain ☐
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel ✓ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas/Unit Pengaduan/Bagian yang menangani komplain

- Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	7. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 8. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 9. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 10. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 11. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai

	variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 12. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. 13. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Outcome
Satuan Pengukuran	Indeks
Numerator (pembilang)	Tidak ada
Denominator (penyebut)	Tidak ada
Target Pencapaian	≥ 76,61
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh pasien Kriteria Eksklusi : Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{100\% \times \text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}}$
Metode Pengumpulan Data	Survei
Sumber Data	Hasil survei
Instrumen Pengumpulan Data	Kuisisioner (terlampir)
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan
Cara Pengambilan Sampel	Stratified Random Sampling
Periode Pengumpulan Data	Semesteran
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Semesteran, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas

**KAMUS INDIKATOR MUTU SETIAP UNIT
RS PRIMA HUSADA MALANG TAHUN 2023**

1. Instalasi Gawat Darurat
- a. Angka ketidaklengkapan pengisian form SBAR

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan pengisian form SBAR
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien
Dimensi Mutu	Keselamatan

Tujuan	Mengukur ketidaklengkapan pengisian form SBAR oleh PPA.
Definisi Operasional	1. Form SBAR merupakan form komunikasi yang diisi oleh PPA. 2. Form SBAR harus diisi lengkap oleh PPA setelah mendapat instruksi lewat telpon dari DPJP.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah form SBAR yang tidak lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh form SBAR
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh form SBAR yang diisi tidak lengkap . Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah form SBAR yang tidak lengkap}}{\text{Jumlah seluruh form SBAR}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir SBAR
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang

b. Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert

Judul Indikator	Angka Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan
Definisi Operasional	Obat high alert adalah obat-obatan yang memiliki risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan penempelan label pada obat high alert di gudang farmasi, depo farmasi rawat inap, dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu tertentu

Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian kesalahan penempelan label pada obat high alert di gudang farmasi, depo farmasi rawat inap, dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditulis oleh DPJP Eksklusi : pasien rawat jalan dan rawat inap
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Besar Sampel	Jumlah kejadian penempelan label pada obat high alert
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian kesalahan penempelan label pada obat high alert
Periode Pengumpulan Data	Bulanan □
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi farmasi

c. Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi

Judul Indikator	Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi
Definisi Operasional	Penandaan pada pasien operasi dan rekam medis pasien operasi dengan organ 2 sisi merupakan kegiatan memberikan tanda pada organ yang akan dilakukan operasi khususnya pada organ yang memiliki 2 sisi (bukan organ tunggal) dan pengisian penandaan pada rekam medis
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan tindakan/operasi
Dimensi Mutu	Keselamatan
Dasar pemikiran / alasan pemilihan indicator	Ketidaklengkapan dalam penandaan operasi baik berupa tidak adanya tanda disisi tubuh pasien ataupun tidak adanya bukti penandaan direkam medis pasien dapat berisiko menimbulkan kejadian operasi salah lokasi atau salah sisi yang sangat merugikan pasien.
Numerator	Jumlah pasien operasi (2 sisi) yang tidak dilakukan penandaan pada periode waktu tertentu.
Denominator	Jumlah seluruh pasien operasi (2 sisi) yang tidak dilakukan penandaan pada periode waktu yang sama
Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Rm, rawat inap, iko

Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	Rm
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

d. Angka ketidaklengkapan asesmen awal keperawatan IGD

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan asesmen awal keperawatan IGD
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	3. Mengukur kepatuhan perawat dalam melengkapi asesmen awal keperawatan IGD 4. Menjamin kelengkapan asesmen awal keperawatan IGD.
Definisi Operasional	7. Asesmen awal keperawatan IGD adalah asesmen pengkajian yang dilakukan oleh perawat IGD. 8. Ketidaklengkapan asesmen awal keperawatan IGD adalah Asesmen keperawatan IGD yang tidak diisi lengkap oleh perawat IGD.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah asesmen awal keperawatan IGD yang tidak lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh asesmen awal keperawatan IGD
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua asesmen awal keperawatan IGD Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah asesmen awal keperawatan IGD yang tidak lengkap}}{\text{Jumlah seluruh asesmen awal keperawatan IGD}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Ceklist dokumen rekam medik
Sumber Data	Dokumen rekam medik
Instrumen Pengumpulan Data	Ceklist dokumen rekam medik
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Penanggung Jawab	Kepala ruang IGD
------------------	------------------

e. Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Keselamatan Pasien.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur ketidaklengkapan pengisian permintaan form radiologi yang berasal dari unit
Definisi Operasional	1. Permintaan form radiologi adalah form yang harus diisi oleh dokter, perawat atau bidan saat menemukan pasien yang memerlukan pemeriksaan radiologi. 2. Ketidaklengkapan pengisian permintaan form radiologi adalah ketidaklengkapan pengisian form radiologi yang dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah permintaan form radiologi yang tidak lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh permintaan form radiologi yang lengkap maupun yang tidak lengkap
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua permintaan form radiologi yang tidak lengkap. Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah permintaan form radiologi yang tidak lengkap}}{\text{Jumlah seluruh permintaan form radiologi yang lengkap maupun yang tidak lengkap}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	SIMRS
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

f. Angka ketidaklengkapan asesmen awal medis IGD

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan asesmen awal medis IGD
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan dokter dalam melengkapi asesmen awal medis IGD

	2. Menjamin kelengkapan asesmen awal medis IGD.
Definisi Operasional	1. Asesmen awal medis IGD adalah asesmen pengkajian yang dilakukan oleh dokter IGD. 2. Ketidaklengkapan asesmen awal medis IGD adalah Asesmen medis IGD yang tidak diisi lengkap oleh medis IGD.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah asesmen awal medis IGD yang tidak lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh asesmen awal medis IGD
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua asesmen awal medis IGD Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah asesmen awal medis IGD yang tidak lengkap}}{\text{Jumlah seluruh asesmen awal medis IGD}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Ceklist dokumen rekam medik
Sumber Data	Dokumen rekam medik
Instrumen Pengumpulan Data	Ceklist dokumen rekam medik ☐
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang IGD

g. Efektifitas SIMRS dalam upaya menunjang peningkatan mutu rumah sakit

Judul Indikator	Efektifitas SIMRS dalam upaya menunjang peningkatan mutu rumah sakit
Dasar Pemikiran	Undang-Undang tentang Rumah Sakit.
Dimensi Mutu	Efektifitas SIMRS
Tujuan	Tergambarnya keefektifitasan dari SIMRS dalam peningkatan mutu rumah sakit.
Definisi Operasional	Kefektifan SIMRS yang digunakan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah hari SIMRS efektif dan tidak bermasalah dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah hari dalam satu bulan
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria inklusi : SIMRS diandra

	Kriteria eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah hari SIMRS efektif dan tidak bermasalah dalam satu bulan}}{\text{Jumlah hari dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	SIMRS
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir observasi SIMRS
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling/Stratified Random sampling</i> (berdasar poliklinik rawat jalan)
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medik

h. Kejadian petugas tertusuk jarum

Judul Indikator	Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien. 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19). 4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD). 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan penyuntikan yang aman serta pengelolaan benda tajam.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menurunkan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada Staf RS Prima Husada sehingga mencegah penularan penyakit dan mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	Kejadian tertusuk jarum bekas pasien merupakan kejadian yang berhubungan mengenai suatu prosedur penyuntikan yang salah yang dilakukan petugas saat melakukan proses injeksi atau pemasangan infus pasien.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Kejadian
Numerator (pembilang)	Kejadian tertusuk jarum
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi:

	Staf medis yang melakukan tindakan penyuntikan / pemasangan infus dengan jarum. Kriteria Eksklusi: Jarum belum digunakan ke pasien.
Formula	Jumlah kejadian tertusuk jarum
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi & laporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Pajanan
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

i. Angka tidak terpasangnya gelang identitas pasien IGD

Judul Indikator	Angka tidak terpasangnya gelang identitas pasien IGD
Dasar Pemikiran	5. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Agar terhindar dari dari kesalahan identifikasi pasien
Definisi Operasional	Gelang identitas pasien merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi pasien. Pemasangan gelang identifikasi pasien adalah salah satu cara untuk menghindari kesalahan identifikasi pasien. Setiap pasien rumah sakit berhak diidentifikasi secara benar. Dengan demikian pasien akan mendapat Tindakan yang tepat selama menjalani masa perawatan. Resiko salah pasien, salah Tindakan, atau salah prosedur pun dapat dicegah.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien IGD yang tidak terpasang gelang identitas
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien IGD yang terpasang gelang identitas
Target Pencapaian	0 %
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh pasien di IGD yang terpasang gelang identitas Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien di IGD yang tidak terpasang gelang identitas}}{\text{Jumlah total pasien IGD yang terpasang gelang identitas}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Ruang

j. Kejadian pasien jatuh di IGD

Judul Indikator	Kejadian Pasien Jatuh Di IGD
Area	IGD
Kategori Indikator	Kepatuhan dalam pencegahan resiko jatuh pasien di IGD
Perspektif	Proses bisnis internal
Sasaran Strategis	Terwujudnya sistem penyelenggaraan sistem pelayanan di RS berbasis mutu dan keselamatan pasien dengan cara pencegahan resiko pasien jatuh
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah terjadinya pasien jatuh
Definisi Operasional	Kejadian Pasien jatuh
Frekuensi pengumpulan data	Harian
Periode waktu pelaporan data	Bulan
Frekuensi analisa data	Triwulan
Metode analisa data	Menggunakan <i>Line Chart</i>
Numerator	Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan di IGD yang jatuh pada periode waktu tertentu.
Denominator	Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan di IGD yang jatuh pada periode waktu yang sama
Formula pengukuran	Numerator
Sumber data	Sistem pelaporan
Standar	0
Kriteria penilaian	Inklusi : Semua kasus pasien beresiko jatuh
PJ pengumpul data	Penanggungjawab data unit
Cakupan data	Pasien IGD
Publikasi data	-
Referensi	-

k. Kejadian respon time > 5 menit

Judul Indikator	Kejadian Respon Time >5 Menit
Area	IGD
Kategori Indikator	Kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan

Perspektif	Proses bisnis internal
Dimensi Mutu	Efektifitas
Tujuan	Terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat
Definisi Operasional	Emergency Response Time (Waktu Tanggap) adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien dilakukan triage di IGD sampai mendapat pelayanan dokter. Triage adalah usaha pemilahan pasien sebelum ditangani berdasarkan tingkat kegawatdaruratan / trauma / penyakit dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan sumber daya yang ada..
Jenis Indikator	Proses
Frekuensi pengumpulan data	Harian
Periode waktu pelaporan data	Bulan
Frekuensi analisa data	Triwulan
Metode analisa data	Menggunakan <i>Line Chart</i>
Numerator	Jumlah pasien gawat, darurat dan gawat darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan dalam waktu ≤ 5 menit
Denominator	Jumlah seluruh pasien gawat, darurat dan gawat darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit
Formula pengukuran	Numerator
Sumber data	<i>Sistem Pelaporan</i>
Standar	0
Kriteria penilaian	1. Inklusi : Semua pasien gawat, pasien darurat dan pasien gawat darurat 2. Eksklusi : Situasi bencana (disaster) / musibah massal
PJ pengumpul data	PJ MUTU
Instrumen Pengambilan Data	1. Laporan Kunjungan IGD
Metode pengumpulan data	Concurrent
Cakupan data	Total Populasi
Referensi	-

2. Instalasi Rawat Inap
- a. Angka kelengkapan penulisan perawat dalam CPPT

Judul Indikator	Angka kelengkapan penulisan perawat dalam CPPT
Dasar Pemikiran	6. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kepatuhan perawat dalam kelengkapan penulisan perawat dalam CPPT
Definisi Operasional	Pendokumentasian catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) merupakan alat komunikasi dalam asuhan terintegrasi yang dilakukan oleh professional

	pemberi asuhan (PPA) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dokumentasi tidak lengkap akan membentuk kerangka kerja yang tidak baik yang akan memperburuk kerangka kerja PPA, karena dokumentasi penting kaitannya dengan praktek professional PPA untuk menghindari kejadian tak diharapkan (KTD)
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah penulisan CPPT oleh perawat yang lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah total penulisan CPPT oleh perawat
Target Pencapaian	100 %
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh total penulisan CPPT oleh perawat Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah penulisan CPPT oleh perawat yang lengkap}}{\text{Jumlah total penulisan CPPT oleh perawat}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Rekam Medis
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Ruang

b. Prosentase pulang atas permintaan sendiri

Judul Indikator	Prosentase pulang atau permintaan sendiri
Dasar Pemikiran	Pasien pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur prosentase pasien pulang atau permintaan sendiri
Definisi Operasional	1. Pasien pulang tanpa ada persetujuan DPJP 2. Pasien pulang atas permintaan sendiri 3. Pasien pulang dalam kondisi belum membaik
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien pulang atas permintaan sendiri
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien rawat inap
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua pasien pulang atas permintaan sendiri Kriteria Eksklusi: Pasien pulang atas advice DPJP

Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien pulang atas permintaan sendiri}}{\text{Jumlah seluruh pasien rawat inap}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

c. Angka rujukan horizontal FKRTL

Judul Indikator	Angka rujuk horizontal FKRTL
Dasar Pemikiran	Pasien rujuk horizontal FKRTL
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur prosentase pasien Pasien rujuk horizontal FKRTL
Definisi Operasional	Pasien dirujuk dari rawat inap ke rumah sakit dengan tipe yang sama seperti RS. Prima Husada
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rujuk horizontal FKRTL
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien rawat inap
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua pasien rujuk horizontal FKRTL Kriteria Eksklusi: Semua pasien rujuk vertikal FKRTL
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rujuk horizontal FKRTL}}{\text{Jumlah seluruh pasien rawat inap}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

d. Angka walk through audit

Judul Indikator	Angka Walk Through Audit
Dasar Pemikiran	Angka Walk Through Audit
Dimensi Mutu	Mutu pelayanan

Tujuan	Mengukur angka Walk Through Audit
Definisi Operasional	Angka tercapainya mutu pelayanan rumah sakit
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Angka Walk Through Audit
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	100
Kriteria	Kriteria Inklusi: Angka Walk Through Audit pasien rawat jalan dan rawat inap Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Angka Walk Through Audit
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

3. Instalasi Care Unit
- a. Angka kelengkapan asesmen pasien tahap terminal

Judul Indikator	Angka kelengkapan assessment pasien tahap terminal
Dasar Pemikiran	kelengkapan assessment pasien tahap terminal
Dimensi Mutu	Dokumen rekam medis
Tujuan	Mengukur angka kelengkapan assessment pasien tahap terminal
Definisi Operasional	Mengukur angka kelengkapan assessment pasien tahap terminal
Jenis Indikator	input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah assessment pasien tahap terminal yang lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah assessment pasien tahap terminal yang lengkap dan tidak lengkap
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua assesment tahap terminal Kriteria Eksklusi: Bukan assessment tahap terminal
Formula	$\frac{\text{Jumlah assessment pasien tahap terminal yang lengkap}}{\text{Jumlah assessment pasien tahap terminal yang lengkap dan tidak lengkap}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Dokumen rekam medik
Sumber Data	Rekam medik
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>

Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang

b. Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU

Judul Indikator	Angka kelengkapan form keluar masuk ICU
Dasar Pemikiran	kelengkapan form keluar masuk ICU
Dimensi Mutu	Dokumen rekam medis
Tujuan	Mengukur angka kelengkapan form keluar masuk ICU
Definisi Operasional	Mengukur angka kelengkapan form keluar masuk ICU
Jenis Indikator	input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah form keluar masuk ICU yang lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah form keluar masuk ICU yang lengkap dan tidak lengkap
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua form keluar masuk ICU Kriteria Eksklusi: Bukan form keluar masuk ICU
Formula	$\frac{\text{Jumlah form keluar masuk ICU yang lengkap}}{\text{Junlah form keluar masuk ICU yang lengkap dan tidak lengkap}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Dokumen rekam medik
Sumber Data	Rekam medik
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang

4. Instalasi Rawat Jalan

a. Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan

Judul Indikator	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan
Dasar Pemikiran	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit .
Dimensi Mutu	Efektifitas pelayanan terhadap pasien yang berkunjung ke unit rawat jalan
Tujuan	Keterlambatan kedatangan dokter untuk memberikan pelayanan, dapat menurunkan kepuasan pasien yang berkunjung sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit

Definisi Operasional	Angka kejadian kedatangan dokter yang terlambat lebih dari jadwal praktek yang telah disepakati
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah dokter yang datang terlambat lebih dari jadwal yang sudah ditentukan
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh dokter yang praktek dalam waktu yang sama
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Kedatangan dokter lebih dari jadwal praktek yang seharusnya Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah dokter yang datang terlambat lebih dari jadwal yang sudah ditentukan}}{\text{Jumlah seluruh dokter yang praktek dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Data di Unit Poli
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite Medik
Judul Indikator	Ketepatan waktu jam praktek dokter
Dasar Pemikiran	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit .
Dimensi Mutu	Efektifitas pelayanan terhadap pasien yang berkunjung ke unit rawat jalan
Tujuan	Ketepatan waktu jam praktek dokter dapat meningkatkan kepuasan pasien yang berkunjung sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit
Definisi Operasional	Salah satu indicator mutu pelayanan di instalasi rawat jalan rumah sakit adalah ketepatan waktu jam praktek dokter yang telah ditentukan oleh rumah sakit
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah dokter yang datang praktek tepat waktu
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh dokter yang praktek dalam waktu yang sama
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Dokter yang datang praktek tepat waktu

	Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah dokter yang datang praktek tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh dokter yang praktek dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Data di Unit Poli
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite Medik

b. Keterlambatan rekam medis saat pasien periksa

Judul Indikator	Keterlambatan rekam medis saat pasien periksa
Dasar Pemikiran	Adanya keterlambatan rekam medis saat periksa pasien
Dimensi Mutu	Berorientasi pada pasien
Tujuan	Mengetahui jumlah DRM yang terlambat saat periksa pasien
Definisi Operasional	Terjadinya keterlambatan rekam medis saat periksa pasien
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah rekam medis yang terlambat saat pasien periksa
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh rekam medis pasien yang periksa ke poli hari itu
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Keterlambatan rekam medis saat pasien periksa Kriteria Eksklusi:
Formula	$\frac{\text{Jumlah rekam medis yang terlambat saat pasien periksa}}{\text{Jumlah rekam medis pasien yang periksa ke poli hari itu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Rekap data
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	Setiap ada temuan
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart

Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang rekam medis

c. Ketepatan waktu jam praktek dokter

Judul Indikator	Ketepatan waktu jam praktek dokter
Dasar Pemikiran	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit .
Dimensi Mutu	Efektifitas pelayanan terhadap pasien yang berkunjung ke unit rawat jalan
Tujuan	Ketepatan waktu jam praktek dokter dapat meningkatkan kepuasan pasien yang berkunjung sehingga berdampak terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit
Definisi Operasional	Salah satu indicator mutu pelayanan di instalasi rawat jalan rumah sakit adalah ketepatan waktu jam praktek dokter yang telah ditentukan oleh rumah sakit
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah dokter yang datang praktek tepat waktu
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh dokter yang praktek dalam waktu yang sama
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Dokter yang datang praktek tepat waktu Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah dokter yang datang praktek tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh dokter yang praktek dalam waktu yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Data di Unit Poli
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite Medik

5. Maternitas

a. Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) > 30 menit

Judul Indikator	Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) > 30 menit
Dasar Pemikiran	Merupakan program nasional pemerintah untuk mengurangi angka ketrlambatan operasi section caesaria > 30menit
Dimensi Mutu	Keselamatan

Tujuan	Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dengan proses SC < 30 menit									
Definisi Operasional	Section Caesaria adalah proses <u>persalinan</u> dengan melalui <u>pembedahan</u> di mana irisan dilakukan di <u>perut</u> ibu (laparatomi) dan <u>rahim</u> (<u>histerotomi</u>) untuk mengeluarkan <u>bayi</u> yang dilakukan ketika proses persalinan normal melalui <u>vagina</u> tidak memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainnya. dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis anak.									
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome									
Satuan Pengukuran	Persentase									
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yg mengalami keterlambatan operasi section caesaria (SC) > 30 menit pada periode tertentu									
Denominator (penyebut)	Semua pasien yang dilakukan tindakan SC dalam satu periode waktu									
Target Pencapaian	<5%									
Kriteria	Kriteria Inklusi: Tindakan operasi Section Caesaria Cito di suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu Kriteria Eksklusi: Semua Tindakan operasi Section Caesaria di suatu wilayah kerja dalam periode waktu tertentu tetapi tidak termasuk kriteria inklusi									
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yg mengalami keterlambatan operasi section caesaria (SC) > 30 menit pada periode tertentu}}{\text{Jumlah Tindakan SC dalam satu periode tertentu}} \times 100\%$									
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif									
Sumber Data	Sistem pelaporan									
Instrumen Pengumpulan Data	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket	
	N : Numerator D : Denominator									
Besar Sampel	Total sample									
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling									
Periode Pengumpulan Data	Bulanan									
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart									
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan									
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan									

b. Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit

Judul Indikator	Angka keterlambatan penyediaan darah >60 menit
Dasar Pemikiran	Merupakan program nasional pemerintah untuk mengurangi angka ketrlambatan penyediaan darah > 60menit

Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kestinambungan									
Tujuan	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan darah di maternitas									
Definisi Operasional	Keterlambatan penyediaan kebutuhan labu darah untuk pasien > 60 menit									
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome									
Satuan Pengukuran	Persentase									
Numerator (pembilang)	Pasien yang mengalami keterlambatan penyediaan labu darah dalam 1 periode yang di hitung mulai dari mendapatkan advis dokter untuk tranfusi sampai dengan darah datang dari PMI dan di berikan ke pasien									
Denominator (penyebut)	Semua pasien di maternitas yang dilakukan tindakan tranfusi darah									
Target Pencapaian	100%									
Kriteria	Kriteria Inklusi: Pasien yang mengalami keterlambatan penyediaan labu darah dalam 1 periode yang di hitung mulai dari mendapatkan advis dokter untuk tranfusi sampai dengan darah datang dari PMI dan di berikan ke pasien Kriteria Eksklusi: Semua pasien di maternitas yang dilakukan tindakan tranfusi darah tetapi tidak dalam kriteria inklusi									
Formula	Jumlah px yang mengalami keterlambatan penyediaan darah dalam 1 periode waktu tertentu _____x 100% Jumlah px di meternitas yang dilakukan tranfusi darah									
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif									
Sumber Data	Sistem pelaporan									
Instrumen Pengumpulan Data	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket	
	N : Numerator D : Denumerator									
Besar Sampel	Total sample									
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas									
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan									
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart									
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan									
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan									

c. Angka kematian ibu

Judul Indikator	Angka kematian ibu
Dasar Pemikiran	Merupakan program nasional pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu, karena masih ditemukan kasus kematian ibu pasca melahirkan

Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kestinambungan									
Tujuan	Mengurangi angka kematian ibu hamil dan nifas									
Definisi Operasional	Kematian ibu hamil dan nifas di suatu wilayah kerja									
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome									
Satuan Pengukuran	Persentase									
Numerator (pembilang)	ibu hamil dan nifas yang meninggal di suatu wilayah kerja dalam periode waktu yang sama									
Denominator (penyebut)	Semua ibu hamil dan nifas di suatu wilayah dalam periode waktu yang sama									
Target Pencapaian	100%									
Kriteria	Kriteria Inklusi: ibu hamil dan nifas yang meninggal di suatu wilayah kerja dalam periode waktu yang sama Kriteria Eksklusi: Semua ibu hamil dan nifas di suatu wilayah kerja dalam periode waktu yang sama tetapi tidak dalam kriteria inklusi									
Formula	Jumlah ibu hamil dan nifas yang meninggal di suatu wilayah kerja dalam periode waktu yang sama _____x 100% Jumlah ibu hamil dan nifas di suatu wilayah dalam periode waktu yang sama									
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif									
Sumber Data	Sistem pelaporan									
Instrumen Pengumpulan Data	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket	
	N : Numerator D : Denominator									
Besar Sampel	Total sample									
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas									
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan									
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart									
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan									
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan									

d. Angka kematian bayi

Judul Indikator	Angka kematian bayi
Dasar Pemikiran	Merupakan program nasional pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi , karena masih banyak ditemukan kematian bayi di suatu wilayah kerja.

Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kestinambungan																											
Tujuan	Mengurangi angka kematian bayi																											
Definisi Operasional	Kematian bayi baru lahir kemudian meninggal di satu wilayah kerja pada periode yang sama																											
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome																											
Satuan Pengukuran	Persentase																											
Numerator (pembilang)	Bayi yang dilahirkan kemudian meninggal di suatu wilayah dalam satu periode waktu yang sama,tetapi tidak termasuk bayi yang mengalami iufd																											
Denominator (penyebut)	Semua bayi baru lahir																											
Target Pencapaian	100%																											
Kriteria	Kriteria Inklusi: Bayi yang dilahirkan kemudian meninggal di suatu wilayah dalam satu periode waktu yang sama,tetapi tidak termasuk bayi yang mengalami iufd Kriteria Eksklusi: Semua bayi yang lahir di suatu wilayah kerja dalam periode waktu yang sama tetapi tidak termasuk kriteria inklusi																											
Formula	Jumlah bayi yg dilahirkan kemudian meninggal dalam satu periode waktu yang sama x 100% Jumlah bayi yang lahir dalam satu periode waktu tertentu																											
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif																											
Sumber Data	Sistem pelaporan																											
Instrumen Pengumpulan Data	<table><tr><td>No</td><td>Tgl</td><td>Shif</td><td>PIC</td><td>No RM</td><td>Nama px</td><td>N</td><td>D</td><td>Ket</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> N : Numerator D : Denumerator										No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket									
No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket																				
Besar Sampel	Total sample																											
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling																											
Periode Pengumpulan Data	Bulanan																											
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart																											
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan																											
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan																											

e. Kejadian tidak dilakukannya IMD (Insisi Menyusui Dini) pada bayi baru lahir

Judul Indikator	Kejadian tidak melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir
Dasar Pemikiran	Masih ditemukan kejadian tidak melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir
Dimensi Mutu	1. Efektifitas

	2. Keselamatan 3. Kesiambungan																		
Tujuan	• Untuk menghangatkan bayi sesaat setelah lahir • Untuk mempermudah proses pemberian ASI Eksklusif • Meningkatkan bonding antara ibu dan bayi																		
Definisi Operasional	Inisiasi menyusui dini adalah bayi baru lahir yang diletakkan pada dada atau perut sang ibu, secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusui. IMD dilakukan segera setelah bayi dilahirkan yang sesuai dengan kriteria bayi lahir sehat																		
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome																		
Satuan Pengukuran	Persentase																		
Numerator (pembilang)	Bayi baru lahir yang tidak dilakukan IMD																		
Denominator (penyebut)	Semua bayi yang dilahirkan baik secara SC dan persalinan normal di satu unit dalam periode waktu yang sama																		
Target Pencapaian	100%																		
Kriteria	Kriteria Inklusi: Bayi baru lahir yang tidak dilakukan IMD Kriteria Eksklusi: Semua bayi yang dilahirkan baik secara SC dan persalinan normal di satu unit dalam periode waktu yang sama tetapi tidak termasuk dalam kriteria inklusi																		
Formula	Jumlah bayi baru lahir yang tidak melakukan IMD _____x 100% Jumlah semua bayi yang dilahirkan baik secara SC dan persalinan normal di suatu unit dalam periode waktu tertentu																		
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif																		
Sumber Data	Sistem pelaporan																		
Instrumen Pengumpulan Data	<table><tr><td>No</td><td>Tgl</td><td>Shif</td><td>PIC</td><td>No RM</td><td>Nama px</td><td>N</td><td>D</td><td>Ket</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> N : Numerator D : Denominator	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket									
No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket											
Besar Sampel	Total sample																		
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas																		
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan																		
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart																		
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan																		
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan																		

Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

j. Kejadian infeksi nifas

Judul Indikator	Kejadian infeksi nifas
Dasar Pemikiran	Masih sering di temukannya kaejadian infeksi nifas pada ibu post partum
Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kestinambungan
Tujuan	Mengurangi kejadian infeksi nifas pada ibu post partum
Definisi Operasional	• Infeksi nifas adalah semua peradangan yang disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam organ genital pada saat persalinan dan masa nifas • Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38⁰ C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pasca persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama.
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Ibu post partum di satu unit dalam satu periode waktu yang sama yang mengalami infeksi pada masa nifas
Denominator (penyebut)	Ibu post partum di satu unit dalam satu periode waktu yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Ibu post partum di satu unit dalam satu periode waktu yang sama yang mengalami infeksi pada masa nifas Kriteria Eksklusi: Ibu post partum di satu unit dalam satu periode waktu yang sama
Formula	$\frac{\text{Jumlah ibu post partum di satu unit dalam satu periode waktu yang sama yang mengalami infeksi pada masa nifas}}{\text{Jumlah semua ibu post partum dalam satu periode waktu yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif

Sumber Data	Sistem pelaporan									
Instrumen Pengumpulan Data	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket	
	N : Numerator D : Denominator									
Besar Sampel	Total sample									
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas									
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan									
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart									
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan									
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan									

k.
 Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan pemeriksaan standart 10T pada saat ANC
Dasar Pemikiran	Pemeriksaan 10T pada ibu hamil adalah pemeriksaan standar yang wajib di lakukan pada saat ANC
Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kesiambungan
Tujuan	memastikan kesehatan dan tumbuh kembang janin dapat berjalan normal, mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi, serta mempersiapkan masa nifas berjalan normal dan pemberian Asi eksklusif
Definisi Operasional	Pemeriksaan 10T pada ibu hamil adalah pemeriksaan standar yang wajib di lakukan pada saat ANC,yaitu : 1. Timbang berat badan 2. Tekanan darah 3. Tinggi Fundus uteri 4. Pemberian imunisasi Tentanus toksoid(TT) 5. Pemberian Tablet zat besi 6. Tetapkan status gizi yang berhubungan dengan LILA 7. Tes laboratorium (DL, Protein Urine, Hbs Ag,Hiv) 8. Tentukan presentasi janin dan DJJ 9. Tata laksana kasus 10. Temu wicara untuk konseling dan rujuk
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan 10T
Denominator (penyebut)	Jumlah ibu hamil dalam periode waktu tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Jumlah ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan 10T Kriteria Eksklusi:

	Seluruh ibu hamil pada satu unit dan dalam periode waktu yang sama tetapi tidak termasuk dalam kriteria inklusi									
Formula	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan 10T}}{\text{Jumlah semua ibu hamil dalam periode waktu tertentu}} \times 100\%$									
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif									
Sumber Data	Sistem pelaporan									
Instrumen Pengumpulan Data	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket	
	N : Numerator D : Denominator									
Besar Sampel	Total sample									
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas									
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan									
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart									
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Harian, Bulanan									
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan									

I. Kejadian tidak hadirnya dokter spesialis anak pada operasi SC

Judul Indikator	Kejadian ketidakhadiran dokter anak pada operasi SC
Dasar Pemikiran	Masih ditemukan keterlambatan pelayanan kegawatan maternal > 30 menit
Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kesiambungan
Tujuan	Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dokter anak pada saat operasi SC baik cito dan elektif
Definisi Operasional	Ketidakhadiran dokter anak pada saat operasi SC berlangsung baik cito atau elektif
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC pada periode waktu tertentu
Denominator (penyebut)	Jumlah kehadiran dokter anak saat operasi SC pada periode waktu tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Jumlah ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC pada periode waktu tertentu Kriteria Eksklusi: Jumlah kehadiran dokter anak saat operasi SC pada periode

	waktu tertentu																		
Formula	Jumlah ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC pada periode waktu tertentu x 100% Jumlah semua Tindakan SC dalam periode waktu tertentu																		
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif																		
Sumber Data	Sistem pelaporan																		
Instrumen Pengumpulan Data	<table><tr><td>No</td><td>Tgl</td><td>Shif</td><td>PIC</td><td>No RM</td><td>Nama px</td><td>N</td><td>D</td><td>Ket</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> N : Numerator D : Denominator	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket									
No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket											
Besar Sampel	Total sample																		
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas																		
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan																		
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart																		
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Harian, Bulanan																		
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan																		

m. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP

Judul Indikator	Angka capaian pelayanan KB permetode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP
Dasar Pemikiran	Masih ditemukan tidak dilakukannya pelayanan KB permetode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP
Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kestinambungan
Tujuan	Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya bagi ibu dan anak serta mengendalikan pertumbuhan penduduk suatu negara sesuai dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yaitu dengan jalan mengendalikan jumlah kelahiran.
Definisi Operasional	- MKJP : metode kontrasepsi jangka Panjang yang meliputi IUD, MOP/MOW dan implant - Non MKJP : metode kontrasepsi bukan jangka Panjang yang meliputi kondom, suntik, pil, dan obat vagina
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu
Denominator (penyebut)	Jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi:

	Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu Kriteria Eksklusi: Jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu								
Formula	Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah semua pasangan usia subur di suatu wilayah kerja dalam periode waktu tertentu}} \times 100\%$								
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif								
Sumber Data	Sistem pelaporan								
Instrumen Pengumpulan Data	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket
	N : Numerator D : Denominator								
Besar Sampel	Total sample								
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas								
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan								
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart								
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Harian, Bulanan								
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan								

n. Angka capaina pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Judul Indikator	Angka capaian pelayanan KB pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		
Dasar Pemikiran	Masih ditemukan tidak dilakukannya pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran		
Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kesiambungan		
Tujuan	Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya bagi ibu dan anak serta mengendalikan pertumbuhan penduduk suatu negara sesuai dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yaitu dengan jalan mengendalikan jumlah kelahiran.		
Definisi Operasional	- KB pasca persalinan : upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan - KB pasca keguguran : upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran		
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome		
Satuan Pengukuran	Persentase		

Numerator (pembilang)	Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu																		
Denominator (penyebut)	Jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu																		
Target Pencapaian	100%																		
Kriteria	Kriteria Inklusi: Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu Kriteria Eksklusi: Jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu																		
Formula	Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu _____x 100% Jumlah semua pasangan usia subur di suatu wilayah kerja dalam periode waktu tertentu																		
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent 2. Retrospektif																		
Sumber Data	Sistem pelaporan																		
Instrumen Pengumpulan Data	<table><tr><td>No</td><td>Tgl</td><td>Shif</td><td>PIC</td><td>No RM</td><td>Nama px</td><td>N</td><td>D</td><td>Ket</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> N : Numerator D : Denominator	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket									
No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket											
Besar Sampel	Total sample																		
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas																		
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan																		
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart																		
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Harian, Bulanan																		
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan																		

- o. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran

Judul Indikator	Kejadian tidak dilakukannya KB pasca persalinan pada ibu bersalin dan KB pasca keguguran pada ibu pasca keguguran
Dasar Pemikiran	Masih ditemukan tidak dilakukannya pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran
Dimensi Mutu	1. Efektifitas 2. Keselamatan 3. Kestinambungan
Tujuan	Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya bagi ibu dan anak serta mengendalikan pertumbuhan penduduk suatu negara sesuai dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yaitu dengan jalan mengendalikan jumlah kelahiran.
Definisi Operasional	• KB pasca persalinan : upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah

	melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan KB pasca keguguran : upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran																		
Jenis Indikator	Inpute Process.Output. Outcome																		
Satuan Pengukuran	Persentase																		
Numerator (pembilang)	Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu																		
Denominator (penyebut)	Jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu																		
Target Pencapaian	100%																		
Kriteria	Kriteria Inklusi: Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu Kriteria Eksklusi: Jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu																		
Formula	Jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu _____x 100% Jumlah semua pasangan usia subur di suatu wilayah kerja dalam periode waktu tertentu																		
Metode Pengumpulan Data	4. Concurrent 5. Retrospektif																		
Sumber Data	Sistem pelaporan																		
Instrumen Pengumpulan Data	<table><tr><td>No</td><td>Tgl</td><td>Shif</td><td>PIC</td><td>No RM</td><td>Nama px</td><td>N</td><td>D</td><td>Ket</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> N : Numerator D : Denominator	No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket									
No	Tgl	Shif	PIC	No RM	Nama px	N	D	Ket											
Besar Sampel	Total sample																		
Cara Pengambilan Sampel	Total sampling px maternitas																		
Periode Pengumpulan Data	Harian, Bulanan																		
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart																		
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Harian, Bulanan																		
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan																		

6. Instalasi Kamar Operasi
- a. Kejadian keterlambatan operasi > 30 menit

Judul indikator	Kejadian keterlambatan operasi >30 menit
Definisi operasional	Waktu dimulainya operasi adalah tenggang waktu yang dibutuhkan mulai jam direncanakannya operasi sampai dengan terlaksananya operasi saat pasien diinduksi, dengan standar waktu >30 menit

Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan kamar operasi
Dimensi mutu	Efisiensi dan efektifitas
Dasar pemikiran/lasan pemilihan indicator	Pelayanan operasi merupakan gambaran manajemen peningkatan kualitas kamar operasi. Pelayanan operasi merupakan tindakan yang beresiko sehingga harus dilakukan dalam waktu yang cepat
Numerator	Jumlah operasi yang terlambat dilakukan >30 menit dari waktu yang telah ditentukan dalam periode waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh operasi yang dilakukan dalam periode waktu yang sama
Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Rm, rawat inap, iko
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	Lembar transfer pasien (rm 07)
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

b. Kejadian konversi Tindakan anastesi dari local/ regional ke general

Judul indikator	Kejadian konversi tindakan dari local/regional ke general
Definisi operasional	Kejadian konversi regional anastesi ke general anastesi adalah kejadian dilakukannya pembiusan general pada pasien yang sudah mendapatkan pembiusan regional pada saat operasi berlangsung
Tujuan	Memantau adanya konversi pada pasien dengan regional anastesi ke general anastesi
Dimensi mutu	Keselamatan
Numerator	Jumlah pasien yang mengalami konversi regional anastesi ke general anastesi dalam periode waktu tertentu
Denominator	Jumlah pasien yang mengalami konversi regional anastesi ke general anastesi dalam periode waktu yang sama
Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Iko
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren

Sumber data	Penanggung jawab data unit
Pj pengumpul data	Pasien IKO
Publikasi data	Papan publikasi

c. Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anastesi dan sedasi dalam

Judul indikator	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anastesi dan sedasi dalam
Definisi operasional	Adalah kejadian tidak lengkapnya catatan proses monitoring pemulihan anastesi dan sedasi dalam yang tercatat di RM OP003A
Tujuan	Monitoring pasca operasi harus dilakukan oleh tim anastesi (RR) yang bertujuan untuk keselamatan pasien, pencataan harus dilakukan pada lembar rekam medis sebagai bukti
Dimensi mutu	Keselamatan
Dasar pemikiran/ alasan pemilihan indicator	yang tidak terisi dengan lengkap sebagai bukti dari monitoring status fisiologis selama pemulihan pasien setelah dilakukan anastesi dan sedasi dalam
Numerator	Jumlah rm OP003A yang tidak terisi lengkap dalam periode waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh operasi yang dilakukan dalam periode waktu yang sama
Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Iko, Rm
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	RM OP003A
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

d. Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anastesi

Judul indikator	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring status fisiologis selama anastesi
Definisi operasional	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring status fisiologis selama anastesi adalah tidak dilakukannya pencatatan pada rekam medis OP003A sebagai bukti telah dilaksanakan monitoring pada pasien sepanjang anastesi berlangsung
Tujuan	Monitoring proses operasi harus dilakukan oleh tim anastesi bagi keselamatan pasien dan pencataan harus dilakukan pada lembar rekam medis sebagai bukti

Dimensi mutu	Keselamatan
Dasar pemikiran/ alasan pemilihan indicator	Adanya RM OP003A yang tidak terisi dengan lengkap sebagai bukti dari monitoring status fisiologis selama anestesi
Numerator	Jumlah RM OP003A yang tidak terisi lengkap dalam periode waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh operasi yang dilakukan dalam periode waktu yang sama
Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Iko, RM
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	RM OP003A
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

e. Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi

Judul indikator	Kejadian tidak dilakukannya assesmen pra sedasi dalam atau pra anestesi
Definisi operasional	Kejadian tidak dilaksanakannya assesmen pra sedasi atau pra anestesi oleh dokter anestesi adalah tidak terlaksananya suatu bentuk assesmen yang dilakukan oleh dokter anestesi pada pasien yang telah direncanakan operasi dengan bentuk pengkajian pasien sebelum pasien dipindah ke ruang premedikasi kamar operasi.
Tujuan	Agar assesment pra anestesi dapat terlaksana sehingga menjamin keselamatan pasien untuk dilakukannya operasi
Dimensi mutu	Keselamatan
Dasar pemikiran/ alasan pemilihan indicator	Assesment penting dilakukan untuk keselamatan saat proses sedasi dalam atau anestesi
Numerator	Jumlah pasien operasi yang tidak dilakukan assesment pra anestesi
Denominator	-
Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Rm, rawat inap, iko
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	lembar assesment pra anestesi dan cppt
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

f. Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op

Judul Indikator	Kejadian diskrepansi diagnosis pre dan post operasi
Definisi Operasional	Kejadian diskrepansi diagnosis pre-operasi dan post-operasi adalah adanya diagnosis medis sebelum dan setelah operasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dilembar operasi
Tujuan	Mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien, memaksimalkan perawatan dengan perencanaan yang sesuai
Dimensi Mutu	Keselamatan
Dasar pemikiran / alasan pemilihan indicator	Ketepatan disgnosis pembedahan memperlancar pelaksanaan tindakan pembedahan. Ketepatan diagnosis menunjukkan perencanaan yang sesuai
Numerator	Jumlah diagnosis pre-operasi dan post-operasi yang tidak sesuai pada periode waktu tertentu tertentu
Denominator	Jumlah diagnosis pre-operasi dan post-operasi yang tidak sesuai pada periode waktu tertentu yang sama
Formula pengukuran	Numerator
Metodepengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Iko
Frekuensipengumpulan data	1 bulan
Frekuensianalisa data	3 bulan
Metodeanalisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	RM
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Papan publikasi	Papan publikasi

g. Kejadian tidak dilaksanakan SSC

Judul indikator	Angka ketida dilakukannya surgical safety checklist
Definisi operasional	Angka ketidaklengkapan surgical safety checklist adalah tidak lengkapnya pengisian lembar ssc mulai dari sign in sampai dengan sign out
Tujuan	Surgical savety checklist dapat terisi dengan lengkap sehingga dapat menjamin keselamatan pasien operasi
Dimensi mutu	Keselamatan
Dasar pemikiran / alasan pemilihan indicator	Saurgical savety checklost digunakan untuk memantau jalannya operasi dari pasien diruang premedikasi hingga operasi selesai
Numerator	Jumlah ssc yang tidak lengkap selama periode tertentu
Denominator	Jumlah ssc yang dilakukan selama periode tertentu
Formula pengukuran	Numerator
Metodepengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Iko
Frekuensipengumpulan data	1 bulan
Frekuensianalisa data	3 bulan
Metodeanalisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	Lembar ssc or 1

Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

h. Kejadian tidak lengkapnya assesmen pra bedah

Judul indikator	Kejadian tidak lengkapnya assesment pra bedah
Definisi operasional	Assesment pra bedah dikatakan lengkap setelah pasien mrs dan mengisi semua unsur dalam rm assesment pra bedah secara lengkap sebelum dilakukan tindakan
Tujuan	Assesment pra bedah dilakukan dan rm diisi secara lengkap guna melakukan perencanaan bagi pasien.
Dimensi mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran / alasan pemilihan indicator	Dilakukannya assesment pra bedah dan mengisi rm assesment pra bedah secara lengkap dapat memberikan informasi untuk perencanaan perawatan kepada pasien dan tim kesehatan lainnya
Numerator	Jumlah ketidangelengkapan assesment pra bedah dalam periode waktu tertentu
Denominator	Jumlah pasien bedah pada periode waktu tertentu
Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Rm, rawat inap, iko
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	RM assesment pra bedah
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

i. Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi

Judul Indikator	Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi
Definisi Operasional	Penandaan pada pasien operasi dan rekam medis pasien operasi dengan organ 2 sisi merupakan kegiatan memberikan tanda pada organ yang akan dilakukan operasi khususnya pada organ yang memiliki 2 sisi (bukan organ tunggal) dan pengisian penandaan pada rekam medis
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan tindakan/operasi
Dimensi Mutu	Keselamatan
Dasar pemikiran / alasan pemilihan indicator	Ketidaklengkapan dalam penandaan operasi baik berupa tidak adanya tanda disisi tubuh pasien ataupun tidak adanya bukti penandaan direkam medis pasien dapat berisiko menimbulkan kejadian operasi salah lokasi atau salah sisi yang sangat merugikan pasien.
Numerator	Jumlah pasien operasi (2 sisi) yang tidak dilakukan penandaan pada periode waktu tertentu.
Denominator	Jumlah seluruh pasien operasi (2 sisi) yang tidak dilakukan penandaan pada periode waktu yang sama

Formula pengukuran	Numerator
Metode pengumpulan data	Observasi
Cakupan data	Rm, rawat inap, iko
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi analisa data	3 bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Sumber data	Rm
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

j. Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi

Judul indikator	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan operasi
Dasar pemikiran	Permenkes tentang Keselamatan Pasien
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan tindakan operasi (sayatan)
Definisi operasional	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan operasi adalah tidak dilakukannya pengisian formulir penandaan lokasi operasi (rm OP002) oleh dokter operator sebelum operasi
Jenis indikator	Proses
Satuan pengukuran	Presentase
Numerator (penyebut)	Jumlah pasien operasi yg tdk dilakukan penandaan (rm OP002)
Denominator (pembilang)	Jumlah seluruh pasien operasi
Target pencapaian	100%
Formula	Numerator
Metode pengumpulan data	Retrospektif
Sumber data	Lembar formulir penandaan lokasi operasi (rm OP002)
Cakupan data	Rm, rawat inap, iko
Frekuensi pengumpulan data	Harian
Periode waktu pelaporan data	1 Bulan
Metode analisa data	Diagram bar dan tren
Pj pengumpul data	Petugas pengumpul data iko
Publikasi data	Papan publikasi

7. Laboratorium

a. Kejadian kesalahan input hasil laboratorium

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Input Hasil Laboratorium
Dasar Pemikiran	Sering adanya complain dari dokter penanggung jawab yang berkaitan dengan kesalahan hasil laboratorium
Dimensi Mutu	Ketelitian, Keselamatan
Tujuan	Mengukur ketelitian pemberi layanan untuk meminimalisir kejdian kesalahan input hasil demi tercapainya keselamatan pasien
Definisi Operasional	1. Keselamatan Pasien 2. Penginputan Hasil Laboratorium memberikan pengaruh penting dalam upaya pertolongan pada

	pasien. Hasil ini nantinya menjadi acuan dokter dalam menegakkan diagnosis pada pasien.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	-
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua kejadian salah input hasil laboratorium. Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	-
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari: Catatan Data Kesalaahan Input Hasil Laboratorium
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kesalahan Input Hasil Laboratorium
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling / Systematic Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

b. Kejadian Kesalahan Input Hasil Laboratorium

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Input Hasil Laboratorium
Dasar Pemikiran	Sering adanya complain dari dokter penanggung jawab yang berkaitan dengan kesalahan hasil laboratorium
Dimensi Mutu	Ketelitian, Keselamatan
Tujuan	Mengukur ketelitian pemberi layanan untuk meminimalisir kejadian kesalahan input hasil demi tercapainya keselamatan pasien
Definisi Operasional	3. Keselamatan Pasien 4. Penginputan Hasil Laboratorium memberikan pengaruh penting dalam upaya pertolongan pada pasien. Hasil ini nantinya menjadi acuan dokter dalam menegakkan diagnosis pada pasien.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	0
Numerator (pembilang)	-
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua kejadian salah input hasil laboratorium. Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	-
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari:

	Catatan Data Kesalaahan Input Hasil Laboratorium
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kesalahan Input Hasil Laboratorium
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling / Systematic Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

c. Kejadian pengulangan plebotomi saat sampling

Judul Indikator	Kejadian Pengulangan Plebotomi saat Sampling
Dasar Pemikiran	Adanya pengulangan plebotomi saat sampling
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kenyamanan pasien
Tujuan	Mengevaluasi keterampilan petugas pengambil darah serta meminimalisir kejadian pengulangan plebotomi di laboratorium
Definisi Operasional	Plebotomi merupakan metode pengambilan sampel darah dengan cara melubangi vena subcutis, maka dari itu petugas sampling harus melaksanakan tugasnya dengan sikap terampil. Petugas diharapkan meminimalisir kejadian pengulangan plebotomi guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	0
Numerator (pembilang)	-
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua kejadian pengulangan plebotomi saat sampling Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	-
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari: Catatan Data Pengulangan Plebotomi saat Sampling
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir pengulangan plebotomi
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling / Systematic Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☐ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

8. Radiologi

a. Angka keterlambatan pelaporan hasil kritis pasien

Judul Indikator	Angka keterlambatan pelaporan hasil kritis pasien
Dasar Pemikiran	Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan no 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan radiologi
Definisi Operasional	Hasil kritis : hasil pemeriksaan yang termasuk kriteria kritis sesuai kebijakan rumah sakit dan memerlukan penatalaksanaan segera Waktu pelaporan hasil kritis dihitung sejak hasil kritis keluar sampai dengan lapor kepada dokter yang meminta pemeriksaan Radiologi
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Presentase
Numerator (pembilang)	Jumlah hasil kritis radiologi yang dilaporkan ke ruang rawat < 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah hasil kritis radiologi
Target Pencapaian	0 %
Kriteria	inklusi: Semua hasil pemeriksaan radiologi yang memenuhi kategori hasil kritis.
Formula	$N/D \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Concurrent
Sumber Data	Formulir tool pelaporan nilai kritis
Instrumen Pengumpulan Data	Form distribusi serah terima hasil
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Harian
Penyajian Data	<i>Y Tabel</i> <i>v Run chart</i>
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalasi radiologi

9. Instalasi Gizi

a. Kejadian kesalahan pemberian diit

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Diet
Dasar Pemikiran	Adanya laporan dari perawat, petugas gizi maupun pasien bahwa diet yang diberikan tidak sesuai.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mencegah kesalahan pemberian terapi diet sesuai dengan diagnosa pasien. 2. Meningkatkan keamanan pasien dengan memberikan diet yang sesuai.
Definisi Operasional	Ketidaktepatan diet yang disajikan kepada pasien berdasarkan pesanan diet dan rencana asuhan gizi.
Jenis Indikator	Input, proses, output.
Satuan Pengukuran	-
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian diet pada pasien rawat inap pada periode tertentu

Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	-
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir observasi kejadian kesalahan pemberian diet
Besar Sampel	• Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	• Tabel • Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi

b. Kejadian adanya benda asing dalam makanan

Judul Indikator	Kejadian Adanya Benda Asing dalam Makanan
Dasar Pemikiran	Adanya laporan dari perawat, petugas gizi maupun pasien yang pada saat diberikan makanan ada benda asing pada makanan tersebut.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mengukur suatu kejadian tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera yang serius.
Definisi Operasional	Adanya benda asing (ulat, kawat, rambut, dll) pada menu makanan pasien yang disajikan.
Jenis Indikator	Input, proses, output.
Satuan Pengukuran	-
Numerator (pembilang)	Kejadian adanya benda asing dalam makanan pada periode yang tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	-
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir observasi kejadian adanya benda asing dalam makanan
Besar Sampel	• Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	• Tabel • Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi

10. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

a. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Keselamatan Pasien. 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : a. Pemberian pengobatan : pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. b. Prosedur tindakan : tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. c. Prosedur diagnostik : pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. d. Kondisi tertentu : pasien tidak dapat berkomunikasi(dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. Kriteria Eksklusi: Tidak ada

Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

b. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Dasar Pemikiran	1. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional. 2. Kepatuhan terhadap formularium dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan obat-obatan. 3. Formularium rumah sakit disusun berdasarkan masukan-masukan pemberi layanan, dan pemilihannya berdasarkan kepada mutu obat, rasio risiko dan manfaat, berbasis bukti, efektivitas dan efisiensi. Pengadaan obat-obatan di rumah sakit mengacu pada formularium rumah sakit.
Dimensi Mutu	Efisien dan efektif
Tujuan	Terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium nasional.
Definisi Operasional	1. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. 2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional adalah peresepan obat (R/ : <i>recipe</i> dalam lembar resep) oleh DPJP kepada pasien sesuai daftar obat di Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah R/ <i>recipe</i> dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional
Denominator (penyebut)	Jumlah R/ <i>recipe</i> dalam lembar resep yang diobservasi
Target Pencapaian	$\geq 80\%$
Kriteria	Kriteria Inklusi : Resep yang dilayani di RS

	Kriteria Eksklusi : 1. Obat yang diresepkan di luar FORNAS tetapi dibutuhkan pasien dan telah mendapatkan persetujuan komite medik dan direktur.
Formula	$\frac{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional}}{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Lembar resep di Instalasi Farmasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling/ Systematic random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi

c. Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan dalam penyiapan obat untuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap
Definisi Operasional	Jumlah kesalahan yang terjadi dalam tahap peresepan yang dapat teridentifikasi sebelum pasien terpapar akibat dari kesalahan tersebut. Kesalahan penyiapan obat yang dimaksud adalah kesalahan yang teridentifikasi pada telaah obat oleh bagian farmasi, meliputi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, dan benar waktu pemberian.
Jenis Indikator	Output
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah kesalahan kejadian penyiapan obat di depo farmasi rawat jalan dan depo farmasi rawat inap pada periode waktu tertentu
Denominator (penyebut)	Jumlah kesalahan kejadian penyiapan obat di depo farmasi rawat jalan dan depo farmasi rawat inap pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditulis oleh DPJP Eksklusi : Pasien rawat jalan dan rawat inap
Formula	Numerator

Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Besar Sampel	Jumlah kesalahan kejadian penyiapan obat
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian kesalahan penyiapan obat
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi Farmasi

d. Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan dalam penyiapan obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan
Definisi Operasional	Obat LASA (Look Alike Sound Alike) adalah obat - obat yang memiliki nama, rupa dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat
Jenis Indikator	Output
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA di gudang farmasi, depo farmasi rawat inap, dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu tertentu
Denominator (penyebut)	kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA di gudang farmasi, depo farmasi rawat inap, dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditulis oleh DPJP Eksklusi : pasien rawat jalan dan rawat inap
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Besar Sampel	Jumlah kejadian penempelan label pada obat LASA
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart

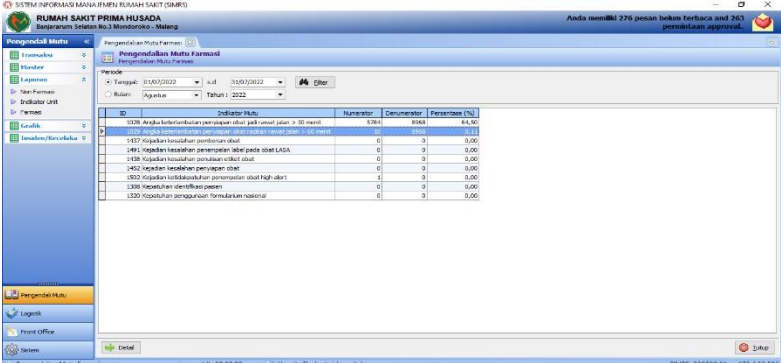
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi Farmasi

e. Angka Keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan > 30menit

Judul Indikator	Angka Keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan > 30menit
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Efektifitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
Definisi Operasional	1. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan mulai resep diterima sampai dengan menerima/ mendapatkan obat jadi dari petugas farmasi. 2. Waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat jadi dalam lembar resep dengan waktu tunggu lebih dari 30 menit sejak resep diterima sampai dengan menerima obat
Denominator (penyebut)	Jumlah resep obat jadi dalam lembar resep yang diobservasi
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep yang dilayani di RS Eksklusi : Resep obat jadi dalam lembar resep dengan waktu tunggu lebih dari 30 menit
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat jadi dalam lembar resep dengan waktu tunggu lebih dari 30 menit sejak resep diterima sampai dengan menerima obat}}{\text{Jumlah resep obat jadi dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Lembar resep di Instalasi Farmasi
Instrumen Pengumpulan Data	Laporan Respon Time Pelayanan Resep
Besar Sampel	Seluruh lembar resep di Instalasi Farmasi
Cara Pengambilan Sampel	
Periode Pengumpulan Data	Bulanan

Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan

f. Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan > 60 Menit

Judul Indikator	Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan > 60 Menit
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Efektifitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi
Definisi Operasional	1. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan adalah rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan mulai resep diterima sampai dengan menerima/ mendapatkan obat racikan dari petugas farmasi. 2. Waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 60 menit
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat racikan dalam lembar resep dengan waktu tunggu lebih dari 60 menit sejak resep diterima sampai dengan menerima obat
Denominator (penyebut)	Jumlah resep obat racikan dalam lembar resep yang diobservasi
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep yang dilayani di RS Eksklusi : Resep obat racikan dalam lembar resep dengan waktu tunggu lebih dari 60 menit
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat racikan dalam lembar resep dengan waktu tunggu lebih dari 60 menit sejak resep diterima sampai dengan menerima obat}}{\text{Jumlah resep obat racikan dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Lembar resep di Instalasi Farmasi
Instrumen Pengumpulan Data	Laporan Respon Time Pelayanan Resep
Besar Sampel	Seluruh lembar resep di Instalasi Farmasi
Cara Pengambilan Sampel	

Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi farmasi

g. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan
Definisi Operasional	Pemberian obat adalah pemberian obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan sesuai dengan resep dokter
Jenis Indikator	Output
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah kesalahan kejadian pemberian obat di depo farmasi rawat inap dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu tertentu
Denominator (penyebut)	Jumlah kesalahan kejadian pemberian obat di depo farmasi rawat inap dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditulis oleh DPJP Eksklusi : pasien rawat jalan dan rawat inap
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Besar Sampel	Jumlah kejadian kesalahan pemberiaan obat
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian kesalahan pemberiaan obat
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi farmasi

h. Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.

Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	a. Mencegah terjadinya kesalahan dosis obat yang diterima pasien b. Meningkatkan keamanan penggunaan obat oleh pasien
Definisi Operasional	Kejadian kesalahan penulisan etiket di rawat jalan dan rawat inap, dimana penulisan etiket terdiri dari nama pasien, nama obat, tanggal resep, dan cara pemakaian obat.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan penulisan etiket obat di depo farmasi rawat inap dan rawat jalan pada periode tertentu
Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian kesalahan penulisan etiket obat di depo farmasi rawat inap dan rawat jalan pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditulis oleh DPJP Eksklusi : pasien rawat jalan dan rawat inap
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Besar Sampel	Jumlah kejadian kesalahan penulisan etiket di rawat jalan dan rawat inap
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian kesalahan penulisan etiket
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi farmasi

i. Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Obat High Alert

Judul Indikator	Angka Ketidakpatuhan Penempelan Obat High Alert
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan
Definisi Operasional	Obat high alert adalah obat-obatan yang memiliki risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan penempelan label pada obat high alert di gudang farmasi, depo farmasi rawat inap, dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu tertentu

Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian kesalahan penempelan label pada obat high alert di gudang farmasi, depo farmasi rawat inap, dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : Resep pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditulis oleh DPJP Eksklusi : pasien rawat jalan dan rawat inap
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Besar Sampel	Jumlah kejadian penempelan label pada obat high alert
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian kesalahan penempelan label pada obat high alert
Periode Pengumpulan Data	Bulanan □
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi farmasi

j. Kejadian Kesalahan Input e-resep

Judul Indikator	Angka Kesalahan Input e-resep
Dasar Pemikiran	1. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin ketepatan pemberian terapi pasien. 2. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan terkait kesalahan inputan e-resep. 3. Untuk mengurangi angka kesalahan inputan e-resep.
Dimensi Mutu	Ketepatan terapi obat
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan
Definisi Operasional	Terjadinya kesalahan inputan e-resep di rawat jalan dan rawat inap, dimana kesalahan inputan e-resep terdiri dari dosis, kandungan obat, aturan minum obat dan cara pemakaian obat.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan input e-resep depo farmasi pada periode waktu tertentu
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh inputan e-resep depo farmasi pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Inklusi : e-resep IGD, IKO, rawat jalan dan rawat inap yang ditulis oleh DPJP Eksklusi : pasien IGD, pasien, IKO, pasien rawat jalan dan rawat inap

Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Insiden Kesalahan Input E-Resep
Besar Sampel	Jumlah kejadian input e-resep
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian kesalahan input e-resep
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi farmasi

k. Efektivitas SIMRS dalam upaya menunjang peningkatan pelayanan kefarmasian

Judul Indikator	Efektivitas SIMRS dalam upaya menunjang peningkatan pelayanan kefarmasian
Dasar Pemikiran	1. Terjadinya keterlambatan pelayanan kefarmasian yang disebabkan oleh SIMRS 2. Untuk menjamin ketepatan pelayanan kefarmasian yang meliputi pengadaan sampai pada penyerahan obat ke pasien 3. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan kepuasan pasien
Dimensi Mutu	Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian
Tujuan	Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian mulai dari pengadaan sampai pada penyerahan obat ke pasien
Definisi Operasional	SIMRS merupakan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang digunakan sebagai wadah jalannya pelayanan di Rumah Sakit
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Kejadian
Numerator (pembilang)	Kejadian SIMRS error
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi : kejadian SIMRS error Kriteria Eksklusi: -
Formula	
Metode Pengumpulan Data	Temuan permasalahan yang terjadi pada SIMRS
Sumber Data	SIMRS
Instrumen Pengumpulan Data	Rekap data
Besar Sampel	Total temuan

Cara Pengambilan Sampel	Setiap ada temuan
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalasi farmasi

Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

Judul Indikator	Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes. 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD).
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	1. Mengukur kejadian petugas tertusuk jarum. 2. Menjamin keselamatan petugas dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, <i>droplet</i> dan <i>airborne</i>). 3. Pelayanan kefarmasian klinis diantaranya terdapat dispensing sediaan steril yang meliputi pencampuran obat injeksi dengan pelarut yang tepat menggunakan spuit sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya insiden tertusuk jarum oleh petugas.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	angka
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang tertusuk jarum
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang melakukan dispensing aseptik menggunakan spuit di waktu yang sama
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua petugas yang melakukan dispensing aseptik menggunakan spuit Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan

Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi Kejadian Tertusuk Jarum
Besar Sampel	Jumlah kejadian tertusuk jarum
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian tertusuk jarum
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi

Kejadian Terkena Pemanas Mesin press Puyer

Judul Indikator	Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
Dasar Pemikiran	4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Kejadian petugas terkena pemanas mesin press puyer
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menjamin keselamatan petugas dengan cara mengurangi risiko terkena pemanas mesin press puyer
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Pelayanan kefarmasian diantaranya adalah penyiapan obar racikan puyer yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya petugas terkena pemanas mesin press puyer.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang terkena pemanas mesin press puyer
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua petugas yang melakukan penyiapan obat racikan puyer Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi Kejadian Petugas terkena mesin press puyer
Besar Sampel	Jumlah kejadian terkena mesin press puyer
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kejadian terkena mesin press puyer
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi
------------------	--------------------------

11. Pengadaan Farmasi

e. Kekosongan stok sediaan Farmasi

Judul Indikator	Angka Kekosongan Stok Sediaan Farmasi
Dasar Pemikiran	1.PMK RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2.Standart akreditasi RS Kemenkes R.I 2022.
Dimensi Mutu	Efektifitas dan efisiensi
Tujuan	Terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS
Definisi Operasional	Kekosongan sediaan farmasi di pabrik atau distributor yang mempunyai kontrak kerjasama dengan RS
Jenis Indikator	Output
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah sediaan farmasi yang mengalami kekosongan
Denominator (penyebut)	Jumlah sediaan farmasi di Intalasi Farmasi
Target Pencapaian	≤ 10%
Kriteria	Inklusi : Sediaan farmasi di Intalasi Farmasi Eksklusi : Sediaan farmasi yang mengalami kekosongan
Formula	$\frac{\text{Jumlah sediaan farmasi yang mengalami kekosongan}}{\text{Jumlah sediaan farmasi di Intalasi Farmasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Catatan data
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Kekosongan Obat
Besar Sampel	Seluruh sediaan farmasi di Intalasi Farmasi
Cara Pengambilan Sampel	Laporan kekosongan stok sediaan farmasi
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala instalansi farmasi

12. PPI

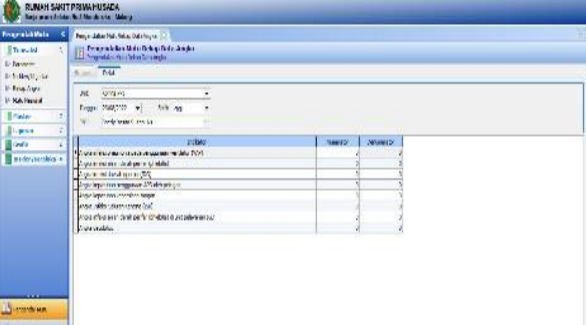
14. Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Judul Indikator	Infeksi Daerah Operasi (IDO)
Dasar Pemikiran	7. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien 8. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 10. Center for Healthcare related infections surveillance and prevention. 11. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan perawatan pasien yang menjalankan operasi.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya infeksi daerah operasi yang terjadi di rumah sakit untuk dapat dilakukan upaya menurunkan angka Infeksi Daerah Operasi (IDO).
Definisi Operasional	Infeksi Daerah Operasi adalah Infeksi yang terjadi pada daerah insisi daerah operasi dalam waktu 30 hari tanpa implan dan satu tahun dengan implan pasca bedah atau 90 hari pasca bedah dengan prosedur pemasangan implan. Kriteria Infeksi: 1) Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang diatas fascia; 2) Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptik; 3) Sengaja dibuka oleh dokter karena terdapat tanda peradangan, kecuali hasil biakan negatif (paling sedikit terdapat satu dari tanda-tanda infeksi berikut ini : nyeri, bengkak lokal, Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.
Jenis Indikator	Proses & Output
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus Infeksi Daerah Operasi (IDO)
Denominator (penyebut)	Jumlah kasus operasi
Target Pencapaian	<2%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Kasus operasi. Kriteria Eksklusi: Prosedur sirkumsisi ; Stitch abscess
Formula	$\frac{\text{Jumlah kasus IDO}}{\text{Jumlah kasus operasi}} \times 100$
Metode Pengumpulan Data	Sensus Harian
Sumber Data	Hasil observasi & laporan
Instrumen Pengumpulan Data	Pengendali Mutu SIMRS 

Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

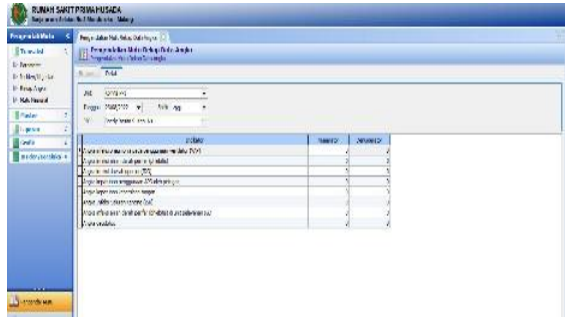
15. Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)

Judul Indikator	Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator/ <i>Ventilator Associated Pneumonia</i> (VAP)
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 4. <i>Center for Healthcare related infections surveillance and prevention</i> . 5. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan perawatan pasien yang terpasang ventilator.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kejadian VAP untuk dapat dilakukan upaya menurunkan pneumonia akibat penggunaan ventilator (VAP)
Definisi Operasional	Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) adalah infeksi saluran napas bawah yang mengenai parenkim paru setelah pemakaian ventilasi mekanik > 48 jam, dan sebelumnya tidak ditemukan tanda-tanda infeksi saluran napas. Kriteria : Ditemukan minimal dari tanda dan gejala klinis : - Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) tanpa ditemui penyebab lainnya. - Leukopenia ($< 4.000\text{ WBC/mm}^3$) atau Leukositosis ($\geq 12.000\text{ SDP/mm}^3$). - Untuk penderita berumur ≥ 70 tahun, adanya perubahan status mental yang tidak ditemui penyebab lainnya. Minimal disertai 2 dari tanda berikut: - Timbulnya onset baru sputum purulen atau perubahan sifat sputum. - Munculnya tanda atau terjadinya batuk yang memburuk atau dyspnea (sesak napas) atau tachypnea. - Ronki basah atau suara napas bronchial. - Memburuknya pertukaran gas, misalnya desaturasi O_2 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 240$), peningkatan kebutuhan oksigen, atau perlunya peningkatan ventilator. Dasar diagnosis : Adanya bukti secara radiologis adalah jika ditemukan > 2 foto serial : Infiltrat baru atau progresif yang

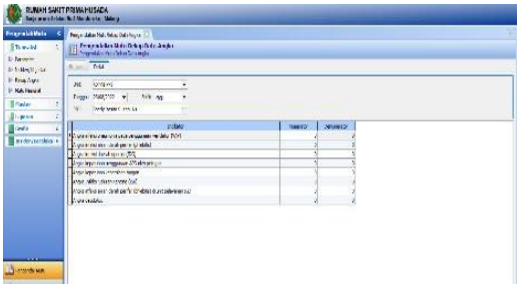
	menetap ; Konsolidasi ; Kavitasi ; Pneumatocoles pada bayi berumur < 1 tahun
Jenis Indikator	Proses & Output
Satuan Pengukuran	Permil
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus infeksi Ventilator Associated Pneumonia (VAP)
Denominator (penyebut)	Jumlah lama hari pemakaian atau terpasang Ventilator
Target Pencapaian	<5,8‰
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien yang menggunakan Ventilator > 48 jam. Kriteria Eksklusi: Pasien dengan riwayat Pneumonia sebelum terpasang ventilator
Formula	Jumlah kasus infeksi VAP <u>dibagi</u> Jumlah hari pemakaian atau terpasang Ventilator <u>x 1000</u>
Metode Pengumpulan Data	Sensus Harian
Sumber Data	Hasil observasi & laporan
Instrumen Pengumpulan Data	Pengendali Mutu SIMRS 
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

16. Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)

Judul Indikator	Infeksi Saluran Kemih (ISK)
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 4. <i>Center for Healthcare related infections surveillance and prevention.</i> 5. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan perawatan pasien yang terpasang kateter.

Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya infeksi saluran kencing yang terjadi di rumah sakit untuk dapat dilakukan upaya menurunkan angka infeksi saluran kencing (ISK).
Definisi Operasional	Infeksi Saluran Kencing (ISK) adalah Infeksi yang terjadi sebagai akibat dari pemasangan kateter > 48 jam Kriteria : Gejala dan Tanda : - Umum : demam, urgensi, frekuensi, disuria, nyeri suprapubik - Usia < 1 tahun : demam, hipotermi, apneu, bradikardi, letargia, muntah-muntah. - Nitrit dan/atau leukosit esterase positif dengan carik celup (dipstick). - Pyuria > 10 leukosit/LPB sedimen urin atau >10 leukosit/mL atau > 3 leukosit/LPB dari urine tanpa dilakukan sentrifus. - Terdapat koloni mikroorganisme pada hasil pemeriksaan urine kultur. - Diagnosis dokter yang merawat menyatakan adanya ISK. Terapi dokter sesuai ISK
Jenis Indikator	Proses & Output
Satuan Pengukuran	Permil
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus Infeksi Saluran Kemih (ISK)
Denominator (penyebut)	Jumlah lama hari pemakaian kateter urin menetap
Target Pencapaian	<4,7‰
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien rawat inap dengan kateter terpasang > 48 jam. Kriteria Eksklusi: Pasien yang terpasang kateter urin ≤ 48 jam
Formula	Jumlah kasus ISK <u>dibagi</u> Jumlah lama hari pemakaian kateter urin menetap x 1000
Metode Pengumpulan Data	Sensus Harian
Sumber Data	Hasil observasi & laporan
Instrumen Pengumpulan Data	Pengendali Mutu SIMRS 
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

17. Angka Infeksi Aliran Darah Perifer (Phlebitis)

Judul Indikator	Infeksi Aliran Darah Perifer (Phlebitis)
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 4. <i>Center for Healthcare related infections surveillance and prevention.</i> 5. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan perawatan pasien yang terpasang vena perifer (infus).
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya infeksi aliran darah perifer yang terjadi di rumah sakit untuk dapat dilakukan upaya menurunkan angka Infeksi aliran darah perifer (Plebitis).
Definisi Operasional	Phlebitis merupakan inflamasi pada vena, yang ditandai dengan adanya daerah yang merah, nyeri dan pembengkakan di daerah penusukan atau sepanjang vena (Brunner dan Sudarth, 2002). Angka phlebitis pasca pemasangan kateter vena perifer yang timbul <72 jam pemasangan.
Jenis Indikator	Proses & Output
Satuan Pengukuran	Persentase
Jumlah kasus Phlebitis	Jumlah kasus Phlebitis
Denominator (penyebut)	Seluruh pasien yang terpasang kateter intravena
Target Pencapaian	≤5%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien rawat inap yang terpasang kateter intravena. Kriteria Eksklusi: Pasien rawat inap yang belum mengganti tusukan kateter intravena >72 jam
Formula	$\frac{\text{Jumlah kasus phlebitis}}{\text{Seluruh pasien yang terpasang kateter intravena}} \times 100$
Metode Pengumpulan Data	Sensus Harian
Sumber Data	Hasil observasi & laporan
Instrumen Pengumpulan Data	Pengendali Mutu SIMRS 
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan

Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

18. Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (Pajanan)

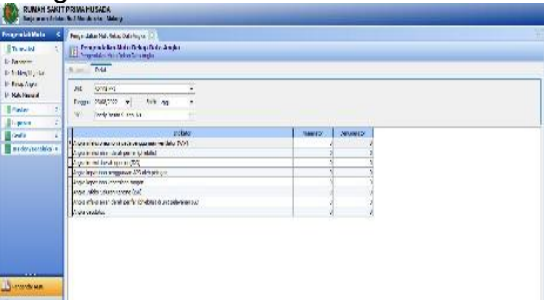
Judul Indikator	Kejadian Petugas Tertusuk Jarum Bekas Pasien (Pajanan)
Dasar Pemikiran	7. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien. 8. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19). 10. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 11. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD). 12. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan penyuntikan yang aman serta pengelolaan benda tajam.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menurunkan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada Staf RS Prima Husada sehingga mencegah penularan penyakit dan mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	Kejadian tertusuk jarum bekas pasien merupakan kejadian yang berhubungan mengenai suatu prosedur penyuntikan yang salah yang dilakukan petugas saat melakukan proses injeksi atau pemasangan infus pasien.
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Kejadian
Numerator (pembilang)	Kejadian tertusuk jarum
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi: Staf medis yang melakukan tindakan penyuntikan / pemasangan infus dengan jarum. Kriteria Eksklusi: Jarum belum digunakan ke pasien.
Formula	Jumlah kejadian tertusuk jarum
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi & laporan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan Pajanan ☐
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan ☐
Penyajian Data	Tabel

	√ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

19. Kejadian ditemukannya biakan kuman dalam alat steril

Judul Indikator	Kejadian ditemukannya biakan kuman dalam alat steril
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien. 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19). 4. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD). 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan dan menjaga sterilitas alat medis.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan kepatuhan Staf RS Prima Husada dalam menggunakan alat medis dan menjaga sterilitasnya
Definisi Operasional	Kejadian ditemukannya kuman yang ada didalam alat steril yang ditemukan melalui pemeriksaan mikrobiologi
Jenis Indikator	Output
Satuan Pengukuran	Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah temuan kuman pada alat steril
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi: Alat-alat steril di unit CSSD. Kriteria Eksklusi: -
Formula	Jumlah temuan kuman pada alat steril
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil pemeriksaan mikrobiologi alat steril
Instrumen Pengumpulan Data	Laporan Hasil Pemeriksaan ☐
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan ☐
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

20. Angka Decubitus

Judul Indikator	Angka Decubitus
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 4. <i>Center for Healthcare related infections surveillance and prevention.</i> 5. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan perawatan pasien yang menjalani tirah baring lama.
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kejadian decubitus yang terjadi di rumah sakit untuk dapat dilakukan upaya menurunkan angka decubitus.
Definisi Operasional	Pasien yang menderita decubitus akibat tirah baring di rumah sakit
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Permil
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian decubitus
Denominator (penyebut)	Jumlah lama hari tirah baring
Target Pencapaian	1%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Semua pasien rawat inap tirah baring Kriteria Eksklusi: Pasien yang masuk rawat inap sudah mengalami decubitus
Formula	Jumlah kejadian decubitus <u>dibagi</u> Jumlah lama hari tirah baring $\times$ <u>1000</u>
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Pengendali Mutu SIMRS 
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

13. PIPP

1. Angka kepuasan peserta BPJS

Judul Indikator	Angka kepuasan peserta BPJS
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman penyusunan Survei Kepuasan
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada peserta BPJS
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan peserta bpjs
Definisi Operasional	Kepuasan adalah hasil pendapat dan penilaian peserta BPJS terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah peserta BPJS yang puas
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh peserta BPJS
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Jumlah seluruh peserta yang menggunakan BPJS Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah peserta BPJS yang puas}}{\text{Jumlah seluruh peserta BPJS}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Survei
Sumber Data	Hasil survei
Instrumen Pengumpulan Data	Rekap
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas

2. Angka kepatuhan tindak lanjut dan penyelesaian keluhan peserta BPJS

Judul Indikator	Angka kepatuhan tindak lanjut dan penyelesaian keluhan peserta bpjs
Dasar Pemikiran	Undang- - undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Dimensi Mutu	Berorientasi pada pasien

Tujuan	Tergambarnya kepatuhan tindak lanjut dan penyelesaian keluhan pasien sebagai bentuk pemenuhan hak pasien
Definisi Operasional	Kecepatan waktu tanggap komplain adalah rentang waktu Rumah sakit dalam menanggapi keluhan tertulis, lisan atau melalui media massa melalui tahapan identifikasi, penetapan <i>grading</i> risiko, analisis hingga tindak lanjutnya
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah keluhan peserta BPJS yang di tindak lanjuti dan diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh keluhan peserta BPJS
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua keluhan peserta BPJS Kriteria Eksklusi:
Formula	$\frac{\text{Jumlah keluhan peserta BPJS yang di tindak lanjuti dan diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan}}{\text{Jumlah seluruh keluhan peserta BPJS}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Data sekunder dari catatan komplain
Instrumen Pengumpulan Data	1. Laporan tindak lanjut 2. Formular complain
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas/ Unit Pengaduan/ Bagian yang menangani komplain

14. SDM

3. Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK

Judul Indikator	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK
Dasar Pemikiran	Undang - undang cipta kerja No 11 tahun 2020
Dimensi Mutu	Pengurusan SIP/SIK
Tujuan	Mengukur keterlambatan pengurusan SIP/SIK
Definisi Operasional	Kejadian keterlambatan nakes dan nakes lain dalam mengurus SIP/SIK .
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Kejadian
Numerator (pembilang)	Tidak ada
Denominator (penyebut)	Tidak ada
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh keterlambatan pengurusan SIP/SIK . Kriteria Eksklusi:

	Tidak ada
Formula	-
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	List pengumpulan SIP/SIK
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	<i>Total sample</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala SDM

4. Angka kedisiplinan staf terhadap finger print

Judul Indikator	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print
Dasar Pemikiran	Undang - undang cipta kerja No 11 tahun 2020
Dimensi Mutu	Tepat waktu
Tujuan	Tergambarnya kedisiplinan staf dalam melakukan finger print.
Definisi Operasional	Kedisiplinan staf adalah ketepatan waktu staf dalam melakukan finger print dan dilakukan saat datang dan pulang.
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah staf yang disiplin melakukan finger print
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh staf yang melakukan finger print dan yang tidak melakukan finger print
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua hasil staf yang disiplin melakukan finger print. Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah staf yang disiplin melakukan finger print}}{\text{Jumlah seluruh staf yang melakukan finger print dan yang tidak melakukan finger print}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	SIMRS
Instrumen Pengumpulan Data	SIMRS- finger spot ☐
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel ☒ Run chart

Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala SDM

5. Angka keterlambatan kehadiran

Judul Indikator	Angka keterlambatan kehadiran
Dasar Pemikiran	Data kehadiran staf melalui finger print
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mengukur keterlambatan staf
Definisi Operasional	Angka staf yang melakukan keterlambatan kehadiran
Jenis Indikator	Input, proses, output.
Satuan Pengukuran	-
Numerator (pembilang)	Jumlah staf terlambat
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria	-
Formula	Numerator
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Sistem pelaporan
Instrumen Pengumpulan Data	Data Finger print
Besar Sampel	• Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non Probability Sampling - Consecutive Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	• Tabel • Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi

15. Instalasi Rekam medis

1. Angka kejadian nomor rekam medis ganda

Judul Indikator	Angka kejadian nomor rekam medis ganda
Dasar Pemikiran	Terjadinya nomor rekam medis pasien lebih dari satu yang di input dalam SIMRS
Dimensi Mutu	Berorientasi pada pasien
Tujuan	Mengetahui kejadian nomor rekam medis ganda
Definisi Operasional	Terjadinya nomor rekam medis pasien lebih dari satu yang di input dalam SIMRS
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah nomor rekam medis satu pasien lebih dari satu dalam satu hari
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh nomor rekam medis satu pasien dalam satu hari
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi :

	Nomor rekam medis pasien lebih dari satu yang di input dalam SIMRS Kriteria Eksklusi: Nomor rekam medis pasien tidak ganda
Formula	$\frac{\text{Jumlah nomor rekam medis satu pasien lebih dari satu dalam satu hari}}{\text{Jumlah seluruh nomor rekam medis satu pasien dalam satu hari}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Temuan SIMRS
Sumber Data	SIMRS
Instrumen Pengumpulan Data	Rekap data
Besar Sampel	Total temuan
Cara Pengambilan Sampel	Setiap ada temuan
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang rekam medis

2. Angka keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan > 1x 24 jam

Judul Indikator	Angka keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan >1x24 jam
Dasar Pemikiran	Adanya keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan >1x24 jam
Dimensi Mutu	Berorientasi pada pasien
Tujuan	Mengetahui jumlah DRM rawat jalan yang kembali ke rekam medis >1x24 jam
Definisi Operasional	Terjadinya keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan yang kembali ke rekam medis >1x24 jam
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah DRM rawat jalan yang terlambat Kembali ke rekam medis >1x24 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh DRM rawat jalan yang keluar dalam satu hari
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan yang kembali ke rekam medis >1x24 jam Kriteria Eksklusi: Pengembalian DRM tepat waktu
Formula	$\frac{\text{Jumlah DRM rawat jalan yang terlambat Kembali ke rekam medis >1x24 jam}}{\text{Jumlah seluruh DRM rawat jalan yang keluar dalam satu hari}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Rekap data
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	Setiap ada temuan

Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang rekam medis

16. Keuangan
- a. Angka keterlambatan pembayaran klaim

Judul Indikator	Angka keterlambatan pembayaran klaim
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan 2. Rumah sakit memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap pihak asuransi dan perusahaan
Dimensi Mutu	Ketepatan waktu penagihan
Tujuan	Mengukur keterlambatan pembayaran klaim
Definisi Operasional	Kejadian keterlambatan pembayaran klaim pasien asuransi maupun perusahaan yang lebih dari tanggal 5 .
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas klaim yang terlambat dikirim ke pihak asuransi atau perusahaan > tanggal 5
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh berkas klaim asuransi maupun perusahaan
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh berkas klaim asuransi dan perusahaan . Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	-
Metode Pengumpulan Data	Ceklist
Sumber Data	Ceklist pembayaran klaim
Instrumen Pengumpulan Data	SIMRS mutu
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	<i>Total sample</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	□ Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Keuangan

- b. Kejadian piutang umum tidak tertagih

Judul Indikator	Kejadian piutang umum tidak tertagih
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan 2. Rumah sakit memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap pihak asuransi dan perusahaan
Dimensi Mutu	Ketepatan waktu penagihan

Tujuan	Tergambarnya kejadian piutang pasien umum yang tidak tertagih.
Definisi Operasional	Kejadian umum piutang tidak tertagih adalah kejadian piutang dari pasien umum yang tidak terbayar atau tertagih ke pasien.
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Angka
Numerator (pembilang)	Tidak ada
Denominator (penyebut)	Tidak ada
Target Pencapaian	0
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien dengan status umum dan tidak memiliki asuransi kesehatan. Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	Tidak ada
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	SIMRS
Instrumen Pengumpulan Data	SIMRS keuangan
Besar Sampel	Total sampling
Cara Pengambilan Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala SDM

17. K3RS

- a. Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR

Judul Indikator	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR
Dasar Pemikiran	Standar Akreditasi Rumah Sakit STARKES 2022
Dimensi Mutu	Efektifitas, keselamatan
Tujuan	APAR ready for use 24 jam
Definisi Operasional	Kepatuhan petugas dalam melakukan preventif pengecekan APAR yang dilakukan secara berkala
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah APAR yang diperiksa
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh APAR
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Jumlah seluruh APAR di Rumah Sakit Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah APAR yang diperiksa

	x 100%					
	Jumlah seluruh APAR					
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif					
Sumber Data	Laporan kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR					
Instrumen Pengumpulan Data	Formula	Tanggal				
		1	2	3	4	5
	Numerartor (N)	-	-	-	-	-
	Denominator (D)	-	-	-	-	-
	Total (N)	-	-	-	-	-
	Total (D)	-	-	-	-	-
Formula pengukuran = N/D x 100%						
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)					
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling					
Periode Pengumpulan Data	Bulanan					
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart					
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan					
Penanggung Jawab	Kepala Ruang					

b. Kejadian kebakaran di ruangan

Judul Indikator	Kejadian kebakaran di ruangan
Dasar Pemikiran	Standar Akreditasi Rumah Sakit STARKES 2022
Dimensi Mutu	Efektifitas, keselamatan
Tujuan	Untuk antisipasi penanganan dan penanggulangan kebakaaran
Definisi Operasional	Suatu kejadian kebakaran (Code Red) di ruangan
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Kejadian
Numerator (pembilang)	Kejadian kebakaran di ruangan
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua ruangan yang berpotensi terjadi kebakaran Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	Jumlah kejadian kebakaran
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Laporan kejadian kebakaran di ruangan
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Laporan kebakaran
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Sampel	Total Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Y Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung jawab	Kepala Asuransi Center

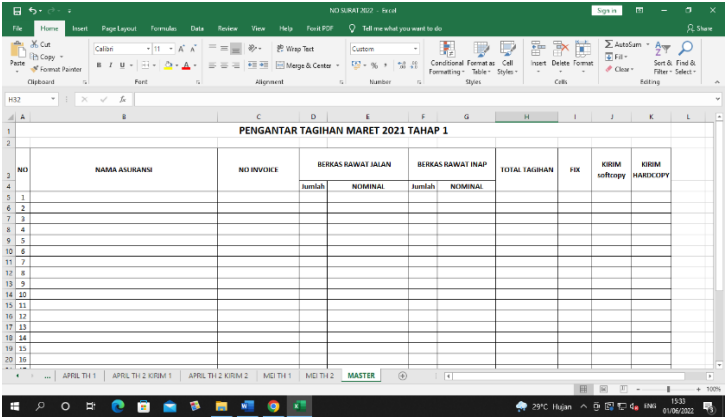
b. Angka keterlambatan klaim asuransi swasta

Judul indikator	Angka keterlambatan klaim asuransi swasta
Dasar Pemikiran	1. UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 2. Rumah sakit harus memperhatikan adanya keterlambatan klaim asuransi swasta
Dimensi mutu	1. Efisiensi 2. Efektifitas
Tujuan	terselenggaranya klaim asuransi swasta yang sesuai standar klaim yang telah ditentukan
Definisi Operasional	Pengiriman klaim asuransi swasta sesuai dengan jadwal yang telah disepakati yaitu 1 bulan 2 kali pengiriman pada tanggal 16 pada bulan tersebut dan tanggal 5 pada bulan berikutnya Klaim Jasa Raharja dikirim setelah pasien pulang
Jenis Indikator	Input
Satuan pengukuran	Presentase
Numerator (pembilang)	Jumlah klaim asuransi swasta yang terlambat dikirim dalam 1 bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah total klaim asuransi swasta dalam 1 bulan
Target Pencapaian	0%
Kriteria :	Inklusi : jumlah klaim asuransi swasta rawat jalan dan rawat inap dalam 1 bulan Eksklusi : jumlah berkas klaim asuransi swasta rawat jalan dan rawat inap dalam 1 bulan yang dikirim setelah tanggal 16 pada bulan tersebut dan tanggal 5 pada bulan sebelumnya

Formula	$\frac{\text{Jumlah klaim asuransi swasta yang terlambat dikirim dalam 1 bulan}}{100\%} \times \text{Jumlah total klaim asuransi swasta dalam 1 bulan}$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Klaim asuransi swasta hasil verifikasi
Instrumen Pengambilan Data	Table jumlah pasien asuransi swasta setiap bulan 
Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Sampel	Total Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Y Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung jawab	Kepala Asuransi Center

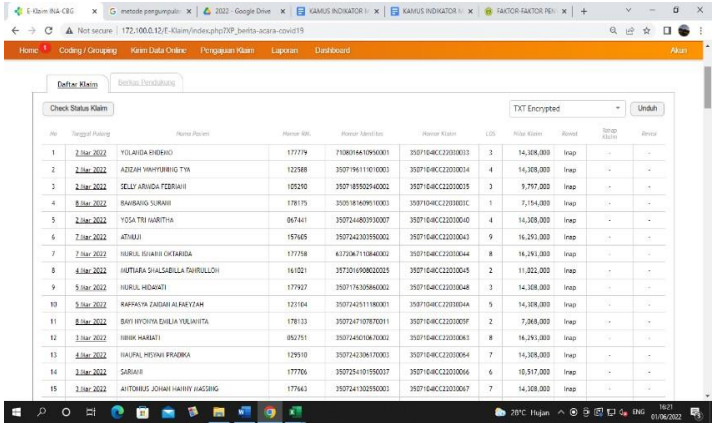
c. Angka keterlambatan klaim BPJS ketenagakerjaan

Judul indikator	Angka keterlambatan klaim bpjs ketenagakerjaan
Dasar Pemikiran	1. Peraturan pemerintah RI No. 45 th 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 2. Rumah sakit harus memperhatikan adanya keterlambatan klaim BPJS Ketenagakerjaan
Dimensi mutu	1. Efisiensi 2. Efektifitas
Tujuan	terselenggaranya klaim BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai standar klaim yang telah ditentukan
Definisi Operasional	Pengiriman klaim BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati yaitu 1 bulan sekali pengiriman di awal bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya

Jenis Indikator	Input
Satuan pengukuran	Presentase
Numerator (pembilang)	Jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan yang terlambat dikirim dalam 1 bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam 1 bulan
Target Pencapaian	0%
Kriteria :	Inklusi : jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan rawat jalan dan rawat inap dalam 1 bulan Eksklusi : berkas klaim BPJS Ketenagakerjaan rawat jalan dan rawat inap dalam 1 bulan yang di kirim setelah tanggal 10 pada bulan sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan yang terlambat dikirim dalam 1 bulan}}{100\%} \times \text{Jumlah pasien BPJS Ketenagakerjaan dalam 1 bulan}$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Klaim BPJS Ketenagakerjaan hasil verifikasi
Instrumen Pengambilan Data	Table jumlah pasien BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan 
Besar Sampel	Total sempel
Cara Pengambilan Sampel	Total Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Y Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung jawab	Kepala Asuransi Center

d. Angka pending klaim COVID 19

Judul indikator	Angka pending klaim covid-19
-----------------	------------------------------

Dasar Pemikiran	1. Peraturan menteri kesehatan no 443 tahun 2022 tentang sistem pembiayaan covid-19 2. Rumah sakit harus memperhatikan adanya pendingan klaim covid - 19
Dimensi mutu	1. Efisiensi 2. Efektifitas
Tujuan	Terselenggaranya klaim covid-19 yang sesuai standar klaim yang telah ditentukan
Definisi Operasional	Pending klaim covid-19 adalah berkas klaim covid-19 yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan kriteria BPJS dan Kemenkes
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	Presentase
Numerator (pembilang)	Jumlah klaim covid-19 yang di pending dalam 1 bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah klaim covid-19 1 bulan
Target Pencapaian	0%
Kriteria :	Inklusi : jumlah klaim covid-19 rawat jalan dan rawat inap yang terpending dalam 1 bulan Eksklusi : berkas klaim covid-19 rawat jalan dan rawat inap yang tidak terpending dalam 1 bulan
Formula	Jumlah klaim covid-19 yang di pending dalam 1 bulan 100% Jumlah klaim covid-19 dalam 1 bulan X
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	BPJS
Instrumen Pengambilan Data	Table jumlah klaim covid-19 setiap bulan 
Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Sampel	Total Sampling

Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	γ Tabel $\sqrt$ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung jawab	Kepala Asuransi Center

e. Kejadian penolakan klaim asuransi swasta dan BPJS ketenagakerjaan

Judul indikator	Kejadian penolakan klaim asuransi swasta dan bpjs ketenagakerjaan
Dasar Pemikiran	1. Peraturan pemerintah RI No. 45 th 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 2. UU RI No. 40 th 2014 tentang perasuransian 3. Rumah sakit harus memperhatikan adanya penolakan klaim asuransi swasta dan bpjs ketenagakerjaan
Dimensi mutu	1. Efisiensi 2. Efektifitas
Tujuan	Terselenggaranya klaim asuransi swasta dan bpjs kesehatan yang sesuai standar klaim yang telah ditentukan
Definisi Operasional	Penolakan klaim asuransi swasta dan bpjs ketenagakerjaan adalah berkas klaim yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh asuransi swasta dan bpjs ketenagakerjaan
Jenis Indikator	Proses
Satuan pengukuran	-
Numerator (pembilang)	-
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0
Kriteria :	Inklusi : jumlah klaim asuransi swasta dan bpjs ketenagakerjaan rawat jalan dan rawat inap yang ditolak dalam 1 bulan Eksklusi : berkas klaim asuransi swas dan bpjs ketenagakerjaan rawat jalan dan rawat inap yang tidak ditolak dalam 1 bulan yang di tolak
Formula	-
Metode Pengumpulan Data	retrospektif
Sumber Data	Asuransi Swasta dan BPJS ketenagakerjaan
Instrumen Pengambilan Data	Table klaim asuransi swasta dan bpjs ketenagakerjaan yang ditolak setiap bulan

Besar Sampel	Total sampel
Cara Pengambilan Sampel	Total Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	γ Tabel $\sqrt{}$ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung jawab	Kepala Asuransi Center

f. Angka kelengkapan dokumen rekam medik pasien BPJS rawat inap

Judul indikator	Angka kelengkapan dokumen rekam medis pasien BPJS rawat jalan
Dasar Pemikiran	1. PMK RI No. 269 tahun 2008 tentang rekam medis
Dimensi mutu	1. Efisiensi 2. Efektifitas
Tujuan	Untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Keterangan baik tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik laboratorium, diagnose segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap,
Jenis Indikator	Input
Satuan pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah dokumen rekam medis pasien BPJS yang tidak lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah dokumen rekam medis pasien BPJS yang di setor per hari
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	Inklusi : Jumlah dokumen rekam medis pasien BPJS yang tidak lengkap Eksklusi : jumlah dokumen rekam medis pasien BPJS yang lengkap
Formula	Jumlah dokumen rekam medis pasien BPJS yang tidak lengkap 100% X Jumlah dokumen rekam medis pasien BPJS yang di setor per hari

Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber Data	Buku serah terima dokumen rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Table jumlah dokumen yang disetorkan
Besar Sampel	Total Sampel
Cara Pengambilan Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	$\bar{Y}$ <i>Tabel</i> $\sqrt{}$ <i>Run chart</i>
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan
Penanggung jawab	Kepala Asuransi Center

19. IPSRS
- a. Angka keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1 x 24 jam

Judul Indikator	Angka keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x24 jam						
Dasar Pemikiran	Standar Akreditasi Rumah Sakit STARKES 2022						
Dimensi Mutu	Efektifitas, efisiensi						
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan ketanggapan dalam pemeliharaan alat						
Definisi Operasional	Kecepatan waktu menanggapi alat yang rusak adalah waktu yang dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk tindak lanjut perbaikan						
Jenis Indikator	Proses						
Satuan Pengukuran	Prosentase						
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan alat yang ditanggapi > 24 jam dalam periode waktu tertentu						
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam periode waktu yang sama						
Target Pencapaian	0%						
Kriteria	Kriteria Inklusi : Semua alat yang ada di Rumah Sakit Kriteria Eksklusi: Tidak ada						
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan alat yang ditanggapi > 24 jam dalam periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam periode waktu yang sama}} \times 100\%$						
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif						
Sumber Data	Laporan kerusakan alat dalam periode waktu yang sama						
Instrumen Pengumpulan Data	Formula	Tanggal					Jumlah
		1	2	3	4	5	
	Numerartor (N)	-	-	-	-	-	-
	Denumerator (D)	-	-	-	-	-	-
	Total (N)	-	-	-	-	-	-
	Total (D)	-	-	-	-	-	-

	Formula pengukuran = $N/D \times 100\%$
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling - Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Ruang

20. CS
- a. Angka ketidakpatuhan penggunaan spill kit

Judul Indikator	Angka ketidakpatuhan penggunaan spill kit
Dasar Pemikiran	Adanya ketidakpatuhan penggunaan spill kit
Dimensi Mutu	Kepatuhan penggunaan spill kit
Tujuan	Menilai ketidakpatuhan dalam penggunaan spill kit
Definisi Operasional	Spill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan cairan tubuh pasien seperti darah, muntah atau bahan infeksius lainnya agar tidak membahayakan semua pekerja dan lingkungan sekitarnya
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah ketidakpatuhan penggunaan spill kit
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh penggunaan spill kit pada hari itu
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Penggunaan spill kit Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah ketidakpatuhan penggunaan spill kit}}{\text{Jumlah seluruh penggunaan spill kit pada hari itu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Laporan
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Unit

- b. Angka keterlambatan barang datang di Gudang umum

Judul Indikator	Angka keterlambatan barang datang di Gudang umum
-----------------	--

Dasar Pemikiran	Adanya keterlambatan barang datang di Gudang umum
Dimensi Mutu	Keterlambatan barang datang di Gudang umum
Tujuan	Menilai Keterlambatan barang datang di Gudang umum
Definisi Operasional	Keterlambatan barang datang di Gudang umum adalah keterlambatan yang terjadi karena hambatan pada proses pembelian yang lebih dari 6 harin dari input proses permintaan pembelian di SIMRS
Jenis Indikator	Hasil
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah keterlambatan barang datang di Gudang umum
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh permintaan barang dari Gudang umum
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Permintaan barang dari Gudang umum Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah keterlambatan barang datang di Gudang umum}}{\text{Jumlah permintaan barang dari Gudang umum}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Laporan
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Unit

c. Angka ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit

Judul Indikator	Angka ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit
Dasar Pemikiran	Adanya ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit
Dimensi Mutu	ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit
Tujuan	Menilai ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit
Definisi Operasional	Angka ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit adalah ketidakpatuhan yang dilakukan oleh unit dalam pengambilan barang di Gudang umum melebihi dari jadwal pengambilan
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pengambilan barang oleh unit
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit Kriteria Eksklusi: Tidak ada

Formula	$\frac{\text{Jumlah ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit}}{\text{Jumlah seluruh pengambilan barang oleh unit}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Laporan
Instrumen Pengumpulan Data	-
Besar Sampel	Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non probability Sampling – Consecutive sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Unit

21. Kesekretariatan
- a. Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 3 setiap bulannya

22. Judul Indikator	Angka keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan >1x24 jam
Dasar Pemikiran	Adanya keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan >1x24 jam
Dimensi Mutu	Berorientasi pada pasien
Tujuan	Mengetahui jumlah DRM rawat jalan yang kembali ke rekam medis >1x24 jam
Definisi Operasional	Terjadinya keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan yang kembali ke rekam medis >1x24 jam
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah DRM rawat jalan yang terlambat Kembali ke rekam medis >1x24 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh DRM rawat jalan yang keluar dalam satu hari
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Keterlambatan pengembalian DRM rawat jalan yang kembali ke rekam medis >1x24 jam Kriteria Eksklusi: Pengembalian DRM tepat waktu
Formula	$\frac{\text{Jumlah DRM rawat jalan yang terlambat Kembali ke rekam medis >1x24 jam}}{\text{Jumlah seluruh DRM rawat jalan yang keluar dalam satu hari}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Rekap data
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	Setiap ada temuan

Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang rekam medis

a. Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x24 jam hari kerja

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja
Dasar Pemikiran	Peraturan tata tertib Rumah Sakit Prima Husada Malang
Dimensi Mutu	Responsiveness
Tujuan	Mengukur ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja
Definisi Operasional	Ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1 x 24 jam hari kerja
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah dokumen meeting RS yang dikumpulkan > 1 x 24 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh dokumen meeting RS yang dikumpulkan > 1 x 24 jam
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Jumlah dokumen meeting RS yang dikumpulkan > 1 x 24 jam Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah dokumen meeting RS yang dikumpulkan > 1 x 24 jam}}{\text{Jumlah seluruh dokumen meeting RS}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi Kepatuhan pengumpulan dokumen meeting
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretariat

b. Angka tindak lanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam

Judul Indikator	Angka Tindaklanjut Surat Balasan Ekternal > 2 x 24 jam
-----------------	--

Dasar Pemikiran	Peraturan tata tertib Rumah Sakit Prima Husada Malang
Dimensi Mutu	Responsiveness
Tujuan	Mengukur Tindaklanjut Surat Balasan Eksternal > 2 x 24 jam.
Definisi Operasional	Tindaklanjut Surat Balasan Eksternal yang dilakukan oleh sekretariat rumah sakit > 2 x 24 jam
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah tindaklanjut surat balasan eksternal > 2 x 24 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh surat eksternal yang masuk ke rumah sakit
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi: Jumlah Tindaklanjut Surat Balasan Eksternal > 2 x 24 jam. Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut surat balasan eksternal > 2 x 24 jam}}{\text{Jumlah seluruh surat eksternal yang masuk ke rumah sakit}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Formulir Observasi tindaklanjut surat balasan eksternal > 2 x 24 jam
Besar Sampel	☐ Total sampel (apabila jumlah populasi ≤ 30) ☐ Rumus Slovin (apabila jumlah populasi > 30)
Cara Pengambilan Sampel	<i>Non Probability Sampling – Consecutive Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretariat

23. Laundry

a. Angka keterlambatan penyediaan linen

Judul Indikator	Angka keterlambatan penyediaan linen
Dasar Pemikiran	- Pedoman pelayanan instalasi laundry tentang pemenuhan kebutuhan linen di rumah sakit - Sering terjadi keterlambatan penyediaan linen di ruang rawat inap,jalan dan IKO - Sering terjadi eror di fasilitas pencucian laundry,kurangnya stok linen dan kurangnya tenaga bagian laundry
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit terkait linen
Definisi Operasional	Angka keterlambatan penyediaan linen laundry untuk ruang perawatn irna,irja dan IKO
Jenis Indikator	Input

Satuan Pengukuran	Presentase
Numerator (pembilang)	Jumlah ketersediaan linen untuk pelayanan seperti selimut,sprei sarban,bantal dan skort
Denominator (penyebut)	Jumlah keterlambatan penyediaan linen untuk pelayanan irna,irja dan IKO
Target Pencapaian	100%
Kriteria	linklusi: Semua linen yang berupa sprei, sarban, bantal, skort dan selimut di ruang pelayanan dan perawatan
Formula	$N/D \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil Observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Form distribusi serah terima linen
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Y <i>Tabel</i> Y <i>Run chart</i>
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala bidang penunjang medis

24. CSSD

a. Kejadian ditemukannya instrumen hilang

Judul Indikator	Kejadian diteukannya instrumen hilang
Dasar Pemikiran	- Pedoman pelayanan instalasi steril tentang serah terima instrumen kotor dan penerimaan instrumen bersih di rumah sakit - Sering terjadi kurangnya alat saat proses serah terima kotor dari ruang rawat inap,jalan dan IKO
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit terkait instrumen yg lengkap
Definisi Operasional	Kejadian ditemukannya instrumen hilang ,tertinggal maupun tertukar di ruang irna,irja dan IKO
Jenis Indikator	Input
Satuan Pengukuran	Presentase
Numerator (pembilang)	Jumlah ditemukannya intrumen yang lengkap saat proses serah terima alat kotor dan proses serah terima alat steril
Denominator (penyebut)	Jumlah di temukannya instrumen yang hilang,tertinggal dan tertukar pada saat serah terima alat kotor maupun alat steril
Target Pencapaian	0
Kriteria	linklusi: Semua instrumen yang di setor ke unit sterilisasi
Formula	$N/D \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil Observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Form distribusi serah terima instreumen
Besar Sampel	Total sample
Cara Pengambilan Sampel	<i>Probability Sampling – Simple Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	Y <i>Tabel</i>

	Y Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala bidang penunjang medis

25. Kamar Jenazah

a. Kepatuhan pencatatan data jenazah di buku pencatatan kamar jenazah

Judul Indikator	Kepatuhan pencatatan data jenazah di buku pencatatan kamar jenazah
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien
Dimensi Mutu	Kepatuhan
Tujuan	Mengukur kepatuhan petugas kamar jenazah dalam pencatatan jenazah setiap hari
Definisi Operasional	Kepatuhan petugas kamar jenazah dalam mencatat data jenazah setiap hari .
Jenis Indikator	Proses
Satuan Pengukuran	Persentase
Numerator (pembilang)	Jumlah data jenazah yang dicatat tepat waktu dalam buku pencatatan kamar jenazah dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh jenazah dalam satu bulan
Target Pencapaian	0%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Seluruh data jenazah yang meninggal dalam satu bulan di RS Prima Husada . Kriteria Eksklusi: Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Seluruh data jenazah yang meninggal dalam satu bulan di RS Prima Husada}}{\text{Jumlah seluruh jenazah dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi
Sumber Data	Hasil observasi
Instrumen Pengumpulan Data	Buku pencatatan kamar jenazah
Besar Sampel	Minimal 200 Peluang
Cara Pengambilan Sampel	Non probability Sampling – Consecutive sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala ruang

26. Humas dan Marketing

a. Angka Kunjungan Pasien Rawat Inap >80 pasien perhari

Judul Indikator	Angka kunjungan pasien rawat inpa >80 pasien perhari
-----------------	--

Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	Kunjungan pasien rawat inap
Tujuan	Mengukur angka kunjungan pasien rawat inap
Definisi Operasional	Angka kunjungan pasien rawat inpa >80 pasien perhari
Jenis Indikator	<i>Outcome</i>
Satuan Pengukuran	Indeks
Numerator (pembilang)	Kunjungan pasien rawat inap pada hari itu
Denominator (penyebut)	Kunjungan pasien rawat inap
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien rawat inap Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Kunjungan pasien rawat inap}}{100\% \text{ Kunjungan pasien rawat inap}} \times$
Metode Pengumpulan Data	SIMRS
Sumber Data	SIMRS
Instrumen Pengumpulan Data	SIMRS
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan
Cara Pengambilan Sampel	<i>Stratified Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Semesteran
Penyajian Data	☐ Tabel ☒ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Semesteran, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas

b. Angka Kunjungan Paien Rawat Jalan >250 perhari

Judul Indikator	Angka kunjungan pasien rawat inpa >80 pasien perhari
Dasar Pemikiran	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	Kunjungan pasien rawat jalan
Tujuan	Mengukur angka kunjungan pasien rawat jalan
Definisi Operasional	Angka kunjungan pasien rawat inpa >250 pasien perhari
Jenis Indikator	<i>Outcome</i>
Satuan Pengukuran	Indeks
Numerator (pembilang)	Kunjungan pasien rawat jalan pada hari itu
Denominator (penyebut)	Kunjungan pasien rawat jalan
Target Pencapaian	100%
Kriteria	Kriteria Inklusi : Pasien rawat jalan

	Kriteria Eksklusi : Tidak ada
Formula	$\frac{\text{Kunjungan pasien rawat jalan}}{\text{Kunjungan pasien rawat jalan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	SIMRS
Sumber Data	SIMRS
Instrumen Pengumpulan Data	SIMRS
Besar Sampel	Sesuai tabel Sampel Krejcie dan Morgan
Cara Pengambilan Sampel	<i>Stratified Random Sampling</i>
Periode Pengumpulan Data	Semesteran
Penyajian Data	Tabel √ Run chart
Periode Analisis dan Pelaporan Data	Semesteran, Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bagian Humas

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

